

SENAM SEJATI

TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PEREMPUAN MASA MENOPAUSE

Irna Nursanti • Iba Supra Saba • Dhea Natashia
Dewi Anggraini • Diana Irawati
Heri Rosyati

Editor: Nilawati Uly

Senam Sejati

Terhadap Tekanan Darah Pada Perempuan Masa Menopause

Dr. Irna Nursanti, M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Iba Supra Saba, M.Kep.

Dhea Natasha, S.Kep., Ns., M.S., PhD.

Ns. Dewi Anggraini, S.Kep., M.S.

Diana Irawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB.

Heri Rosyati, SSiT., M.KM.

Editor: Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.



Senam Sejati

Terhadap Tekanan Darah Pada Perempuan Masa Menopause

Penulis: Dr. Irna Nursanti, M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Iba Supra Saba, M.Kep.

Dhea Natashia, S.Kep., Ns., M.S., PhD.

Ns. Dewi Anggraini, S.Kep., M.S.

Diana Irawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB.

Heri Rosyati, SSiT., M.KM.

Editor: Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.

ISBN: 978-623-10-9429-2

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

KATA PENGANTAR

Buku ajar ini disusun sebagai upaya untuk memberikan panduan praktis dan teoritis bagi tenaga keperawatan dan mahasiswa kesehatan dalam memahami serta menerapkan konsep gaya hidup sehat berbasis pemberdayaan diri, khususnya melalui pendekatan Senam SEJATI pada perempuan menopause dengan hipertensi. Setiap bab dalam buku ini tidak hanya membahas teori dasar hipertensi dan menopause, tetapi juga menguraikan strategi konkret dalam asuhan keperawatan, aktivitas fisik, edukasi gaya hidup sehat, serta pentingnya etika dan empati dalam praktik sehari-hari.

Senam SEJATI hadir bukan sekadar sebagai program latihan fisik, tetapi sebagai simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih sehat, mandiri, dan berkualitas. Melalui pendekatan ini, diharapkan perawat mampu menjadi fasilitator perubahan yang menginspirasi klien untuk mengambil peran aktif dalam perawatan dirinya sendiri, membangun kemandirian, dan memperkuat ketahanan kesehatan pribadi.

Perawat bukan hanya pemberi layanan, tetapi juga pendidik, pendamping, dan agen perubahan dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip empatik, menghargai keberagaman budaya, serta memegang teguh etika profesional, perawat mampu membentuk hubungan terapeutik yang kokoh, mendorong perilaku sehat, dan menciptakan dampak positif jangka panjang terhadap kualitas hidup klien.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi praktis dalam mengembangkan praktik keperawatan berbasis humanistik dan pemberdayaan. Lebih dari itu, besar harapan kami bahwa semangat Senam SEJATI dapat menjadi gerakan nyata dalam dunia keperawatan Indonesia: mengajak lebih banyak perempuan untuk hidup lebih sehat, lebih kuat, dan lebih percaya diri menghadapi masa menopause, serta memperkuat kontribusi perawat sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Mari kita bergerak bersama. Mari kita bangkitkan perubahan dari Langkah kecil penuh makna. Karena dari satu Gerakan sehat, lahir sejuta harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Salam,
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP DASAR MENOPAUSE	1
Pengertian dan Fase-Fase Menopause	1
Hormon dan Fisiologi Tubuh	2
Gejala dan Tantangan Psikososial	3
Epidemiologi dan Realitas Menopause di Indonesia	4
BAB 2 HIPERTENSI PADA PEREMPUAN MENOPAUSE.....	7
Definisi dan Klasifikasi Hipertensi.....	7
Patofisiologi Hipertensi	10
Faktor Risiko dan Pemicu pada Masa Menopause.....	12
Komplikasi dan Dampaknya terhadap Kualitas Hidup	14
Penatalaksanaan Medis dan Nonfarmakologis	15
BAB 3 PERAN KEPERAWATAN DALAM MANAJEMEN HIPERTENSI MENOPAUSE	18
Asuhan Keperawatan: Pengkajian, Diagnosa, dan Intervensi....	18
Perencanaan Perawatan dan Edukasi Klien	21
Strategi Komunikasi dan Pendampingan	25
Peran Perawat sebagai Edukator dan Advokat Kesehatan	29
BAB 4 AKTIVITAS FISIK SEBAGAI INTERVENSI KEPERAWATAN.....	32
Manfaat Aktivitas Fisik terhadap Kesehatan Jantung dan Tekanan Darah.....	32

Latihan Fisik pada Lansia dan Perempuan Menopause	35
Panduan Aman untuk Aktivitas Fisik	37
BAB 5 SENAM “SEJATI”: KONSEP, FILOSOFI, DAN GERAKAN	39
Sejarah dan Latar Belakang Pengembangan.....	39
Prinsip Dasar dan Filosofi Senam SEJATI	40
Struktur Gerakan dan Afirmasi Positif.....	42
Menghidupkan Budaya Sehat: Peran Budaya, Religiusitas, dan Afirmasi Positif dalam Senam SEJATI.....	44
BAB 6 IMPLEMENTASI SENAM SEJATI DALAM PRAKTIK	
KEPERAWATAN	46
Prosedur Pelaksanaan Senam.....	46
Adaptasi Gerakan untuk Klien dengan Kondisi Khusus.....	50
Pengajaran Senam kepada Klien dan Keluarga.....	52
Peran Perawat sebagai Fasilitator Latihan	55
BAB 7 PERAN PERAWAT DALAM MENDORONG GAYA HIDUP	
SEHAT DAN KEMANDIRIAN KLIEN	57
Peran Perawat dalam Edukasi Gaya Hidup Sehat	57
Strategi Mendorong Self-Care dan Kemandirian Klien.....	59
Dukungan Berkelanjutan untuk Perubahan Perilaku Positif.....	61
BAB 8 ETIKA, EMPATI, DAN TINDAK LANJUT DALAM PRAKTIK	
KEPERAWATAN	63
Komunikasi Empatik dan Sensivitas Budaya	63
Etika Profesional dalam Pelayanan Keperawatan	65
DAFTAR ISI.....	69

BAB 1

KONSEP DASAR MENOPAUSE

Pengertian dan Fase-Fase Menopause

Menopause merupakan fase alami dalam kehidupan seorang perempuan yang menandai berakhirnya masa reproduksi akibat berhentinya siklus menstruasi secara permanen. Secara klinis, menopause didefinisikan sebagai kondisi ketika seorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, tanpa adanya penyebab patologis lainnya (North American Menopause Society [NAMS], 2022). Hal ini terjadi sebagai akibat dari penurunan fungsi ovarium, yang menyebabkan produksi hormon estrogen dan progesteron menurun secara signifikan.

Masa transisi menuju menopause dikenal sebagai *perimenopause* atau *menopausal transition*, yaitu periode waktu yang dimulai beberapa tahun sebelum menopause ketika perubahan hormonal mulai terjadi dan siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Selama masa ini, kadar estrogen mengalami fluktuasi besar yang dapat menimbulkan berbagai gejala fisik dan emosional seperti hot flashes, gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan gangguan konsentrasi (Santoro, 2016). Perimenopause biasanya berlangsung antara 4 hingga 8 tahun sebelum memasuki menopause secara penuh (Nelson, 2008).

Perubahan hormonal yang terjadi dalam masa transisi ini tidak hanya memengaruhi sistem reproduksi, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kesehatan jantung, metabolisme, dan fungsi kognitif. Oleh karena itu, masa transisi menopause menjadi waktu yang penting bagi intervensi keperawatan dalam hal promosi kesehatan, manajemen gejala, serta edukasi terhadap risiko-risiko kesehatan yang mungkin timbul (Avis et al., 2015).

Pemahaman yang komprehensif tentang definisi menopause dan dinamika masa transisinya sangat penting bagi tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan yang tepat kepada perempuan usia lanjut. Hal ini memungkinkan perawat untuk bersikap lebih empatik dan mampu merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis dan psikososial pasien pada masa tersebut (Chae et al., 2021).

Hormon dan Fisiologi Tubuh

Menopause ditandai oleh perubahan endokrin yang kompleks, terutama penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron akibat menurunnya fungsi folikel ovarium. Estrogen yang semula memiliki peran penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh perempuan—seperti kesehatan jantung, kepadatan tulang, fungsi kognitif, dan elastisitas kulit—mengalami penurunan drastis selama masa transisi menopause (*perimenopause*) hingga pascamenopause (Woods et al., 2020).

Penurunan kadar estrogen menyebabkan terganggunya sistem neuroendokrin, yang memengaruhi pelepasan hormon luteinizing hormone (LH) dan follicle stimulating hormone (FSH). Kadar FSH meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap berkurangnya estrogen, yang menjadi salah satu indikator hormonal khas menopause (Burger et al., 2019). Ketidakseimbangan hormonal

ini juga berkontribusi terhadap munculnya gejala vasomotor seperti hot flashes, keringat malam, gangguan tidur, dan palpitasi.

Secara fisiologis, perubahan hormonal ini berdampak luas terhadap sistem tubuh lainnya. Sistem muskuloskeletal mengalami penurunan massa tulang dan otot karena rendahnya kadar estrogen, meningkatkan risiko osteoporosis dan sarcopenia (Gourlay & Ensrud, 2019). Selain itu, perubahan metabolisme lemak dan peningkatan resistensi insulin menjadikan perempuan menopause lebih rentan terhadap sindrom metabolik dan penyakit kardiovaskular (Muka et al., 2020). Fungsi kognitif pun dapat terpengaruh, di mana beberapa perempuan melaporkan kesulitan berkonsentrasi dan gangguan memori ringan selama fase transisi ini. Perubahan-perubahan fisiologis ini harus menjadi perhatian utama dalam pemberian asuhan keperawatan, karena gejalanya dapat bervariasi antar individu dan memengaruhi kualitas hidup secara signifikan. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan yang holistik dan berbasis bukti sangat dibutuhkan dalam merespons dinamika perubahan hormon dan fisiologis yang terjadi pada perempuan menopause (Santoro & Pinkerton, 2020).

Gejala dan Tantangan Psikososial

Menopause tidak hanya menyebabkan perubahan fisik, tetapi juga bisa memengaruhi kesehatan mental dan emosional. Banyak perempuan mengalami **gejala vasomotor**, seperti rasa panas mendadak (*hot flashes*), keringat malam, dan jantung berdebar. Gejala ini sering membuat tidur terganggu, sehingga tubuh menjadi mudah lelah dan emosi tidak stabil (Avis et al., 2018).

Selain itu, perubahan hormon estrogen juga bisa berdampak pada suasana hati. Beberapa perempuan merasa lebih mudah cemas, sedih, bahkan mengalami depresi ringan. Ada juga yang mengalami **gangguan konsentrasi**, merasa sulit

berpikir jernih, atau sering lupa hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari (Maki & Weber, 2020).

Secara sosial, masa menopause bisa menjadi tantangan karena perempuan sering merasa tidak lagi “produktif” atau kehilangan rasa percaya diri. Apalagi jika gejala yang dialami cukup berat dan mengganggu aktivitas harian. Dukungan dari keluarga, lingkungan, dan tenaga kesehatan sangat penting agar perempuan menopause tetap merasa dihargai dan mampu beradaptasi dengan fase kehidupannya (Ayhan et al., 2022).

Perawat memiliki peran besar dalam mendampingi perempuan menghadapi masa ini. Edukasi, konseling, dan komunikasi yang penuh empati sangat dibutuhkan untuk membantu mereka memahami bahwa menopause adalah proses alami yang bisa dilewati dengan baik jika didukung secara fisik dan psikologis.

Epidemiologi dan Realitas Menopause di Indonesia

Menopause adalah proses biologis alami yang dialami oleh seluruh perempuan yang mencapai usia pertengahan. Di Indonesia, seiring meningkatnya angka harapan hidup perempuan yang kini mencapai rata-rata **74 tahun** (BPS, 2023), maka semakin banyak perempuan yang mengalami masa menopause dan hidup dalam fase pascamenopause selama **20–30 tahun**. Hal ini menunjukkan bahwa menopause bukanlah fase singkat, melainkan bagian penting dari perjalanan hidup perempuan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari tenaga kesehatan, khususnya perawat.

Berdasarkan hasil *Riskesdas* dan berbagai studi nasional, rata-rata usia menopause perempuan Indonesia adalah sekitar **49–51 tahun** (Putri et al., 2021). Namun, ada variasi usia tergantung pada faktor genetik, kondisi kesehatan, gaya hidup, dan status gizi. Misalnya, perempuan dengan indeks massa tubuh rendah, kebiasaan merokok, atau riwayat penyakit autoimun dapat mengalami menopause lebih dini, bahkan sebelum usia 45 tahun, yang disebut sebagai **menopause prematur** (Widyastuti & Harahap, 2020). Sementara itu, menopause yang terjadi setelah usia 55 tahun disebut *late menopause*, yang juga memiliki risiko tertentu seperti peningkatan risiko kanker payudara akibat paparan estrogen lebih lama

Di Indonesia, pemahaman masyarakat tentang menopause masih terbatas. Banyak perempuan belum mengetahui bahwa gejala seperti jantung berdebar, kecemasan, nyeri sendi, atau perubahan suasana hati bisa berkaitan dengan perubahan hormon menopause. Sebagian besar hanya mengenal "berhenti haid", tanpa memahami dampak luas yang menyertai kondisi ini (Sari et al., 2020). Minimnya informasi ini membuat perempuan cenderung tidak mencari bantuan medis atau merasa tidak perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, meskipun gejala yang dialami cukup mengganggu kehidupan sehari-hari.

Selain itu, ada pengaruh budaya dan sosial yang turut membentuk cara perempuan memaknai menopause. Di beberapa komunitas, menopause dianggap sebagai “akhir dari masa produktif” atau “tanda penuaan”, yang bisa menurunkan rasa percaya diri.

Dalam lingkungan kerja atau keluarga, perempuan menopause sering kali tidak mendapatkan perhatian atau ruang untuk membicarakan perubahan yang mereka alami. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko stres, isolasi sosial, dan

gangguan psikologis lain jika tidak didampingi dengan baik oleh keluarga maupun tenaga kesehatan (Ayhan et al., 2022).

Dari sisi pelayanan kesehatan, masih terbatasnya program edukasi khusus menopause di puskesmas maupun fasilitas pelayanan primer menjadi tantangan tersendiri. Padahal, tenaga keperawatan berperan penting dalam memberikan **edukasi preventif, deteksi dini komplikasi, dan dukungan psikososial** pada perempuan menopause. Asuhan keperawatan yang holistik dan berbasis budaya lokal sangat diperlukan untuk membantu perempuan menjalani fase menopause dengan sehat, percaya diri, dan berkualitas.

BAB 2

HIPERTENSI PADA PEREMPUAN MENOPAUSE

Definisi dan Klasifikasi Hipertensi

Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang berada di atas nilai normal, yaitu $\geq 140/90$ mmHg. Kondisi ini sering tidak menimbulkan gejala yang jelas, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalami hipertensi. Namun, beberapa gejala yang bisa muncul antara lain sakit kepala, rasa berat di pundak, jantung berdebar, pusing, lelah, dan penglihatan kabur (Kementerian Kesehatan RI, 2022; American Heart Association, 2020).

Tekanan darah bisa berubah-ubah tergantung posisi tubuh, usia, dan tingkat stres. Hipertensi terjadi ketika tekanan darah meningkat secara terus-menerus, baik tekanan saat jantung memompa darah (*sistolik*) maupun saat jantung beristirahat (*diastolik*) (Tambunan et al., 2021).

Hipertensi meningkatkan risiko berbagai penyakit serius seperti **serangan jantung, gagal jantung, stroke, dan penyakit ginjal**. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko hipertensi antara lain: merokok, obesitas, kurang olahraga, diabetes, kolesterol tinggi, usia tua, dan riwayat keluarga dengan penyakit jantung (Andrianto, 2022).

Menurut panduan JNC 8, target tekanan darah bisa berbeda-beda tergantung usia dan kondisi kesehatan. Misalnya, pada orang tanpa penyakit penyerta berusia ≥ 60 tahun, target tekanan darah adalah $<150/90$ mmHg. Sedangkan pada pasien dengan diabetes atau penyakit ginjal kronis, targetnya adalah $<140/90$ mmHg (Ernawati et al., 2020).

Di Indonesia, hipertensi merupakan salah satu penyebab utama **kematian dan kecacatan**, baik akibat langsung maupun komplikasi yang ditimbulkan seperti stroke dan serangan jantung. Penyakit ini sering ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas, dan banyak kasus terdeteksi saat pasien sudah mengalami gejala lanjut. Oleh karena itu, **pengelolaan hipertensi menjadi prioritas utama** dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang melibatkan tenaga medis dan keperawatan di semua lini (Hiperki, 2015).

Dalam praktik keperawatan, penting bagi perawat dan mahasiswa keperawatan untuk memahami bahwa **klasifikasi hipertensi dapat berbeda-beda tergantung sumber rujukan yang digunakan**. Tiga panduan utama yang sering digunakan dalam praktik dan pendidikan keperawatan adalah **AHA/ACC 2017, JNC 7 (2003), dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI 2022)**. Masing-masing memiliki tujuan dan konteks penggunaan yang berbeda, sehingga pemilihan klasifikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 2.1 Perbandingan Klasifikasi Tekanan Darah

Kategori	AHA/AC 2017 (Whelton et al., 2018)	JNC 7 (2003) (Chobanian et al., 2003)	Kemenkes RI 2022 (Pedoman Kemenkes)
Normal	<120/ <80 mmHg	<120/ <80 mmHg	<120/ <80 mmHg
Normal Tinggi/ Elevated	120 – 129 / <80 mmHg	-	120 – 129 / <80 mmHg
Pre – Hipertensi	-	120–139/ 80–89 mmHg	120–139/ 80–89 mmHg
Hipertensi Tahap 1	130–139/ 80–89 mmHg	140–159/ 90–99 mmHg	140–159/ 90–99 mmHg
Hipertensi Tahap 2	≥140/ ≥90 mmHg	≥160/ ≥100 mmHg	≥160/ ≥100 mmHg
Krisis Hipertensi	>180/ >120 mmHg	-	>180/ >120 mmHg

Sumber: AHA/ACC 2017, JNC 7, dan Kemenkes RI 2022

Untuk praktik klinik di Indonesia, terutama di puskesmas, rumah sakit, dan pelayanan kesehatan primer, disarankan menggunakan klasifikasi dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2022. Klasifikasi ini telah disesuaikan dengan kondisi populasi Indonesia dan digunakan secara resmi dalam berbagai program nasional seperti PIS-PK, Prolanis, serta pedoman pengelolaan hipertensi terintegrasi di layanan primer. Selain itu, pendekatan ini memudahkan tenaga kesehatan dalam menetapkan diagnosis dan merencanakan intervensi yang sesuai dengan sistem pelayanan di Indonesia.

Sementara itu, untuk tujuan akademik, pembelajaran mahasiswa, atau penelitian internasional, disarankan menggunakan klasifikasi AHA/ACC 2017. Panduan ini merupakan standar global terkini yang berbasis *evidence-based medicine*, dan digunakan secara luas dalam literatur ilmiah dan publikasi internasional. Salah satu perbedaan utamanya adalah penekanan pada deteksi dini, di mana tekanan darah 130/80 mmHg sudah dikategorikan sebagai Hipertensi Tahap 1, berbeda dengan pedoman lokal yang menetapkan batas awal hipertensi pada 140/90 mmHg. Dengan memahami klasifikasi AHA/ACC, mahasiswa keperawatan dapat

membaca, memahami, dan mengkritisi jurnal atau praktik klinis dari berbagai negara.

Adapun **JNC 7 (2003)** sebaiknya tidak lagi digunakan sebagai acuan utama karena telah digantikan oleh AHA/ACC 2017. Namun, JNC 7 tetap relevan untuk **tujuan historis** atau ketika membahas **perkembangan klasifikasi hipertensi dari masa ke masa**, misalnya dalam studi literatur atau pengantar topik. JNC 7 juga banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penting untuk tetap dikenali meskipun sudah tidak menjadi standar terbaru.

Berdasarkan hal tersebut, buku ajar ini akan menggunakan **klasifikasi Kemenkes RI 2022** sebagai **acuan utama dalam konteks praktik lokal**, serta menyertakan **klasifikasi AHA/ACC 2017** sebagai **referensi pembanding untuk memperkaya wawasan akademik pembaca**. Penjelasan tentang JNC 7 akan diberikan secara singkat untuk melengkapi pemahaman tentang evolusi pedoman klinis hipertensi.

Patofisiologi Hipertensi

Hipertensi, atau tekanan darah tinggi, merupakan kondisi kronis yang terjadi akibat interaksi kompleks antara berbagai sistem tubuh, termasuk sistem saraf, hormonal, ginjal, pembuluh darah, dan sistem imun. Pemahaman terhadap mekanisme patofisiologi hipertensi penting bagi tenaga keperawatan untuk memberikan asuhan yang tepat dan komprehensif.

Salah satu mekanisme utama dalam perkembangan hipertensi adalah aktivasi berlebihan dari sistem saraf simpatik. Peningkatan aktivitas simpatik menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, peningkatan denyut jantung, dan retensi natrium serta air oleh ginjal, yang semuanya berkontribusi pada

peningkatan tekanan darah. Faktor-faktor seperti stres kronis, obesitas, dan resistensi insulin dapat memicu hiperaktivitas simpatis ini (Whelton et al., 2018).

Selain itu, sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) memainkan peran penting dalam regulasi tekanan darah. Ketika aliran darah ke ginjal menurun, ginjal melepaskan renin, yang memicu serangkaian reaksi menghasilkan angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat. Angiotensin II juga merangsang sekresi aldosteron dari kelenjar adrenal, yang meningkatkan reabsorpsi natrium dan air di ginjal, sehingga meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Aktivasi berlebihan dari RAAS telah dikaitkan dengan hipertensi esensial (Kearney et al., 2020).

Disfungsi endotel, yaitu ketidakmampuan lapisan dalam pembuluh darah untuk mengatur tonus vaskular, juga berkontribusi pada hipertensi. Dalam kondisi normal, endotel menghasilkan zat seperti nitric oxide (NO) yang menyebabkan vasodilatasi. Namun, pada hipertensi, produksi NO menurun dan produksi vasokonstriktor seperti endotelin meningkat, menyebabkan peningkatan resistensi vaskular perifer (Ghiadoni et al., 2019).

Inflamasi kronis dan aktivasi sistem imun juga telah diidentifikasi sebagai faktor penting dalam patofisiologi hipertensi. Sel-sel imun seperti T-helper dan makrofag dapat menginfiltrasi jaringan vaskular dan ginjal, melepaskan sitokin pro-inflamasi yang merusak struktur dan fungsi pembuluh darah, serta mengganggu regulasi tekanan darah (Harrison et al., 2021).

Akhirnya, perubahan struktural pada pembuluh darah, seperti peningkatan kekakuan arteri dan remodeling vaskular, memperburuk kondisi hipertensi. Kekakuan arteri meningkatkan beban kerja jantung dan mempercepat

perkembangan komplikasi kardiovaskular (Laurent & Boutouyrie, 2020). Secara keseluruhan, hipertensi adalah hasil dari interaksi dinamis antara berbagai sistem tubuh, dan pendekatan multidisipliner diperlukan untuk pengelolaannya.

Faktor Risiko dan Pemicu pada Masa Menopause

Menopause adalah fase alami dalam kehidupan seorang perempuan yang menandai berakhirnya siklus menstruasi. Meskipun merupakan proses biologis normal, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi usia onset menopause dan intensitas gejala yang dialami. Memahami faktor-faktor ini penting bagi tenaga keperawatan untuk memberikan edukasi dan intervensi yang tepat kepada pasien.

1. Faktor Risiko Menopause Dini

Beberapa perempuan mengalami menopause lebih awal dari usia rata-rata, yang dikenal sebagai menopause dini atau *premature ovarian insufficiency* (POI).

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko menopause dini meliputi:

- **Genetik dan Kromosom Abnormal:** Kondisi seperti sindrom Turner, di mana terdapat kelainan pada kromosom X, dapat menyebabkan fungsi ovarium terganggu, sehingga mempercepat onset menopause.
- **Penyakit Autoimun:** Gangguan seperti rheumatoid arthritis dan penyakit tiroid autoimun dapat menyerang ovarium, mengganggu produksi hormon, dan mempercepat menopause.
- **Terapi Medis:** Pengobatan kanker seperti kemoterapi dan radioterapi dapat merusak jaringan ovarium, menyebabkan menopause dini.
- **Operasi Bedah:** Pengangkatan ovarium (ooforektomi) atau rahim (histerektomi) dapat memicu menopause secara tiba-tiba, dikenal sebagai menopause bedah.

- **Merokok:** Kebiasaan merokok telah dikaitkan dengan onset menopause yang lebih awal, kemungkinan karena efek toksik pada ovarium.

2. Pemicu dan Faktor yang Memperparah Gejala Menopause

Selain faktor risiko yang memengaruhi usia onset menopause, terdapat juga faktor-faktor yang dapat memperparah gejala menopause:

- **Paparan Logam Berat:** Studi menunjukkan bahwa paparan logam berat seperti kadmium, arsenik, dan merkuri dapat mengganggu keseimbangan hormon dan mempercepat penuaan ovarium.
- **Gaya Hidup Tidak Sehat:** Kurangnya aktivitas fisik, pola makan tinggi lemak, dan konsumsi alkohol berlebihan dapat memperburuk gejala seperti hot flashes dan gangguan tidur.
- **Stres Kronis:** Stres yang berkepanjangan dapat memengaruhi keseimbangan hormon, memperparah gejala seperti perubahan mood dan kelelahan.
- **Kondisi Kesehatan Kronis:** Penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas dapat memperburuk gejala menopause dan meningkatkan risiko komplikasi.

3. Implikasi Kesehatan Pasca-Menopause

Setelah menopause, penurunan kadar estrogen dapat meningkatkan risiko berbagai kondisi kesehatan:

- **Penyakit Kardiovaskular:** Penurunan estrogen berkontribusi pada peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol, meningkatkan risiko penyakit jantung.
- **Osteoporosis:** Kehilangan estrogen mempercepat penurunan kepadatan tulang, meningkatkan risiko patah tulang.

- **Gangguan Kognitif:** Beberapa studi menunjukkan hubungan antara menopause dini dan peningkatan risiko gangguan kognitif serta demensia.

Komplikasi dan Dampaknya terhadap Kualitas Hidup

Perubahan hormon reproduksi yang terjadi seiring bertambahnya usia dapat membawa berbagai dampak pada kesehatan fisik dan emosional perempuan. Salah satu fase penting dalam proses ini adalah menopause, yang sering kali disertai dengan gejala yang mengganggu dan komplikasi jangka panjang. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh, sehingga memerlukan pendekatan penatalaksanaan yang tepat dan menyeluruh.

1. Komplikasi Fisik (Cleveland Clinic, 2024)

Penurunan kadar estrogen selama menopause dapat menyebabkan berbagai perubahan fisik, termasuk:

- **Osteoporosis:** Kehilangan estrogen mempercepat penurunan kepadatan tulang, meningkatkan risiko patah tulang.
- **Penyakit Kardiovaskular:** Penurunan estrogen berkontribusi pada peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol, meningkatkan risiko penyakit jantung.
- **Sindrom Genitourinari Menopause (GSM):** Termasuk gejala seperti kekeringan vagina, nyeri saat berhubungan seksual, dan infeksi saluran kemih berulang.

2. Komplikasi Psikologis dan Kognitif (WHO, 2024)

Perubahan hormonal juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan fungsi kognitif, seperti:

- **Depresi dan Kecemasan:** Perempuan menopause memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan mood.
- **Gangguan Tidur:** Hot flashes dan keringat malam dapat mengganggu tidur, menyebabkan kelelahan dan iritabilitas.
- **Masalah Kognitif:** Beberapa perempuan melaporkan kesulitan konsentrasi dan "brain fog" selama menopause.

3. Dampak terhadap Kualitas Hidup (National Institutes of Health, 2023)

Komplikasi fisik dan psikologis selama menopause dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup perempuan:

- **Penurunan Produktivitas Kerja:** Gejala menopause dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan energi, memengaruhi kinerja kerja.
- **Aktivitas Sosial dan Hubungan Interpersonal:** Gejala seperti depresi dan kecemasan dapat menyebabkan isolasi sosial dan ketegangan dalam hubungan.
- **Kesejahteraan Umum:** Studi menunjukkan bahwa perempuan dengan gejala menopause yang lebih parah melaporkan kualitas hidup yang lebih rendah.

Penatalaksanaan Medis dan Nonfarmakologis

Perubahan hormonal yang terjadi selama masa menopause dapat menimbulkan berbagai gejala yang memengaruhi kualitas hidup perempuan. Penatalaksanaan yang tepat, baik secara medis maupun nonfarmakologis, penting untuk membantu perempuan menjalani masa transisi ini dengan nyaman.

1. Penatalaksanaan Medis (Farmakologis)

Terapi Hormonal Menopause (MHT) merupakan pendekatan farmakologis utama untuk mengatasi gejala menopause, terutama gejala vasomotor seperti *hot flashes* dan keringat malam. MHT dapat berupa estrogen saja atau kombinasi estrogen dan progestogen, tergantung pada kondisi individu. Terapi ini efektif dalam mengurangi gejala menopause dan mencegah osteoporosis. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing individu dan dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis (Magraith & Jang, 2023).

Terapi Nonhormonal juga tersedia bagi perempuan yang tidak dapat atau tidak ingin menggunakan MHT. Beberapa obat yang telah terbukti efektif meliputi:

- **Antidepresan:** Seperti venlafaxine dan paroxetine, yang dapat mengurangi frekuensi dan intensitas *hot flashes*.
- **Gabapentin:** Obat yang awalnya digunakan untuk mengobati kejang, namun juga efektif dalam mengurangi *hot flashes*.
- **Clonidine:** Obat antihipertensi yang dapat membantu mengurangi gejala vasomotor, meskipun penggunaannya mungkin terbatas karena efek samping seperti tekanan darah rendah dan pusing (Mayo Clinic, 2024).

2. Penatalaksanaan Nonfarmakologis

Pendekatan nonfarmakologis dapat menjadi alternatif atau pelengkap terapi medis dalam mengelola gejala menopause. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- **Terapi Kognitif Perilaku (CBT):** Terapi ini telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala vasomotor dan gangguan tidur pada perempuan menopause (Ningtyas & Darmapatni, 2024).

- **Latihan Fisik:** Aktivitas fisik seperti yoga dan senam aerobik dapat membantu mengurangi gejala menopause dan meningkatkan kualitas hidup.
- **Akupresur:** Teknik ini melibatkan penekanan pada titik-titik tertentu di tubuh untuk meredakan gejala seperti insomnia dan *hot flashes* (Ningtyas & Darmapatni, 2024).
- **Aromaterapi:** Penggunaan minyak esensial tertentu, seperti lavender atau sereh, dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur (Masturoh & Anggita, 2023).
- **Konsumsi Makanan Kaya Fitoestrogen:** Makanan seperti kedelai mengandung fitoestrogen yang dapat membantu mengurangi gejala menopause.

BAB 3

PERAN KEPERAWATAN DALAM MANAJEMEN HIPERTENSI MENOPAUSE

Asuhan Keperawatan: Pengkajian, Diagnosa, dan Intervensi

Peran perawat sangat penting dalam membantu perempuan menopause yang mengalami hipertensi. Asuhan keperawatan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup proses pengkajian yang komprehensif, penetapan diagnosa keperawatan yang tepat, serta intervensi yang sesuai dengan kondisi klien dan berbasis bukti ilmiah. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol tekanan darah, mengurangi risiko komplikasi, serta mendukung kualitas hidup klien secara holistik.

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian dimulai dengan mengumpulkan data objektif dan subjektif dari klien. Data subjektif yang perlu diperhatikan antara lain keluhan pusing, sakit kepala, jantung berdebar, kelelahan, hingga gangguan tidur.

Sementara itu, data objektif meliputi pemeriksaan tekanan darah secara berkala, penilaian indeks massa tubuh (IMT), riwayat penyakit penyerta seperti diabetes, serta hasil laboratorium seperti kolesterol dan gula darah.

Selain itu, penting juga mengeksplorasi faktor psikososial dan gaya hidup, termasuk kebiasaan merokok, pola makan, aktivitas fisik, stres, serta dukungan keluarga. Menurut Kurniawan dan Fitria (2021), pengkajian menyeluruh termasuk aspek emosional dan spiritual dapat membantu perawat menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran.

2. Diagnosa Keperawatan

Dalam menangani perempuan menopause dengan hipertensi, perawat perlu menetapkan diagnosa keperawatan yang tepat sebagai dasar perencanaan intervensi. Diagnosa yang digunakan harus mengacu pada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), agar praktik keperawatan sesuai dengan standar nasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

- **Perfusi perifer tidak efektif (D.0027)**

Definisi: Penurunan sirkulasi darah ke ekstremitas yang dapat menyebabkan gangguan fungsi jaringan.

- **Ansietas (D.0080)**

Definisi: Perasaan tidak nyaman atau ketakutan yang tidak jelas penyebabnya, seringkali terkait dengan perubahan fisiologis dan kurangnya pengetahuan tentang kondisi kesehatan.

- **Kurangnya pengetahuan (D.0111)**

Definisi: Kekurangan atau ketidakmampuan untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

- **Risiko ketidakefektifan regimen terapeutik (D.0113)**

Definisi: Risiko kegagalan dalam mengikuti program pengobatan yang ditentukan untuk mencapai tujuan kesehatan yang diinginkan.

3. Intervensi Keperawatan

Berdasarkan diagnosa di atas, intervensi keperawatan yang dapat dilakukan mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) yang diterbitkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Standar ini menjadi panduan bagi perawat dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan keperawatan yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan klien, khususnya pada kasus hipertensi di masa menopause.

- **Pemantauan tekanan darah (I.0203)**

Tujuan: Memantau dan mengevaluasi tekanan darah secara berkala untuk mendeteksi perubahan dan menilai efektivitas terapi.

- **Edukasi manajemen hipertensi (I.0601)**

Tujuan: Memberikan informasi kepada klien tentang pengelolaan hipertensi, termasuk diet rendah garam, pentingnya aktivitas fisik, dan kepatuhan terhadap pengobatan.

- **Manajemen ansietas (I.0602)**

Tujuan: Membantu klien mengidentifikasi penyebab kecemasan dan mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi ketegangan.

- **Dukungan kepatuhan pengobatan (I.0603)**

Tujuan: Mendorong klien untuk mematuhi regimen terapeutik melalui pengingat, konseling, dan dukungan sosial.

Asuhan keperawatan yang komprehensif dan berbasis standar menjadi kunci dalam membantu perempuan menopause mengelola hipertensi secara optimal. Melalui pengkajian yang menyeluruh, penetapan diagnosa berdasarkan SDKI,

serta pelaksanaan intervensi yang sesuai dengan SIKI, perawat tidak hanya berperan dalam aspek klinis, tetapi juga sebagai pendamping, edukator, dan advokat kesehatan. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk memberikan pelayanan yang holistik dan berkesinambungan, yang pada akhirnya meningkatkan kontrol tekanan darah dan kualitas hidup klien. Langkah berikutnya dalam peran keperawatan adalah menguatkan **komunikasi dan pendampingan** yang efektif untuk memastikan keterlibatan aktif klien dalam proses perawatan.

Perencanaan Perawatan dan Edukasi Klien

Merencanakan perawatan merupakan tahapan krusial dalam proses keperawatan, karena menjadi dasar dalam menentukan arah tindakan dan hasil yang ingin dicapai. Pada perempuan menopause dengan hipertensi, perencanaan yang tepat tidak hanya mencakup pengendalian tekanan darah, tetapi juga mencakup peningkatan pengetahuan klien, perubahan gaya hidup, serta penguatan peran keluarga dalam mendukung proses adaptasi terhadap perubahan fisiologis. Dalam praktik profesional, perencanaan ini harus disusun berdasarkan SDKI dan SIKI yang dikeluarkan oleh PPNI.

Perencanaan perawatan disusun berdasarkan diagnosa keperawatan yang telah ditegakkan sebelumnya. Setiap perencanaan harus mencakup **tujuan jangka pendek dan jangka panjang**, indikator luaran, dan strategi edukasi sesuai kondisi klien.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam perencanaan perawatan dan edukasi pada perempuan menopause dengan hipertensi:

1. Menetapkan Tujuan Terukur dan Realistis

Perencanaan perawatan dimulai dari penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (prinsip SMART). Pada perempuan menopause dengan hipertensi, tujuan utama adalah menurunkan dan mengontrol tekanan darah ke rentang normal atau mendekati target, yaitu $<140/90$ mmHg dalam waktu 2–4 minggu tergantung kondisi awal.

Contohnya, jika klien datang dengan tekanan darah 160/100 mmHg, maka tujuan awal bisa ditetapkan: *“Klien mampu menurunkan tekanan darah ke $<150/90$ mmHg dalam 2 minggu melalui kombinasi pengobatan dan edukasi perubahan gaya hidup.”*

Perawat juga dapat menyusun tujuan tambahan, seperti:

- Klien dapat menyebutkan minimal 3 faktor risiko hipertensi dalam 1 minggu.
- Klien mampu melakukan pemantauan tekanan darah mandiri minimal 3 kali per minggu dalam 1 bulan.

Tujuan yang realistis akan memudahkan proses evaluasi dan memotivasi klien untuk berpartisipasi aktif (Kurniawan & Fitria, 2021).

2. Perencanaan Edukasi Gaya Hidup Sehat

Edukasi klien menjadi komponen penting dalam mencegah komplikasi jangka panjang. Rencana edukasi sebaiknya disusun secara bertahap,

dengan pendekatan yang sesuai tingkat literasi dan budaya klien. Konten edukasi mencakup:

- Pola makan sehat: Memperkenalkan pola makan rendah garam dan lemak jenuh, serta meningkatkan asupan serat, sayuran, dan buah-buahan. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah pola DASH diet, yang dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan bila diterapkan konsisten (Santosa et al., 2022).
- Aktivitas fisik rutin: Perawat menyarankan latihan fisik ringan seperti jalan cepat, senam SEJATI, atau yoga 3–5 kali seminggu selama 30 menit.
- Manajemen stres: Mengajarkan teknik relaksasi seperti napas dalam, dzikir, journaling, atau mendengarkan murottal untuk membantu mengendalikan tekanan darah secara emosional.
- Edukasi bahaya merokok dan alkohol: Materi edukasi disampaikan melalui diskusi kelompok, video edukatif, leaflet, atau konseling personal sesuai kondisi klien dan sumber daya yang tersedia.

3. Keterlibatan Keluarga dalam Perencanaan

Keluarga memiliki peran besar dalam mendukung perubahan perilaku klien. Oleh karena itu, perawat perlu mengajak anggota keluarga terdekat untuk ikut serta dalam pertemuan edukasi dan diskusi perawatan.

Peran keluarga dapat dirancang sebagai:

- *Reminder* untuk minum obat tepat waktu,
- Penanggung jawab belanja dan penyediaan makanan sehat di rumah,
- Pendamping dalam olahraga atau senam bersama,
- Pemberi dukungan emosional saat klien merasa cemas atau kurang motivasi.

Rencana edukasi juga sebaiknya memuat cara melibatkan keluarga sebagai bagian dari tim perawatan, bukan sekadar pengamat (Wijaya & Lestari, 2020).

4. Integrasi Spiritualitas dan Nilai Budaya

Banyak perempuan menopause di Indonesia menghadapi masa transisi ini sambil tetap menjalankan peran sebagai istri, ibu, atau tokoh komunitas. Dalam hal ini, pendekatan spiritual dan budaya dapat memperkuat penerimaan dan efektivitas edukasi. Perawat dapat:

- Memberi ruang bagi klien untuk berdiskusi mengenai nilai-nilai keagamaannya terkait kesehatan,
- Menghubungkan makna ikhtiar menjaga tubuh sebagai bagian dari ibadah,
- Mengajak klien merenungkan manfaat kesehatan dari praktik spiritual seperti shalat, puasa, atau dzikir rutin.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik keperawatan holistik yang menempatkan klien sebagai individu yang utuh secara fisik, emosional, dan spiritual (Handayani, 2021).

5. Dokumentasi dan Evaluasi Berkala

Perencanaan perawatan tidak akan bermakna jika tidak didokumentasikan dan dievaluasi secara sistematis.

Perawat perlu mencatat:

- Tujuan yang telah ditetapkan,
- Strategi intervensi yang dilakukan,
- Respons klien terhadap setiap edukasi atau tindakan yang diberikan.

Evaluasi dilakukan secara berkala (harian, mingguan, atau per bulan), dengan membandingkan capaian aktual terhadap tujuan yang telah direncanakan.

Jika tujuan belum tercapai, maka rencana perlu direvisi sesuai respons dan kemampuan klien. Dokumentasi ini juga penting sebagai bukti tanggung jawab profesional dalam praktik keperawatan berbasis standar (NANDA-I, 2021).

Perencanaan keperawatan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam tindakan klinis, tetapi juga menjadi cerminan tanggung jawab perawat dalam memberdayakan klien. Edukasi yang diberikan secara tepat sasaran, terstruktur, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu memungkinkan perempuan menopause dengan hipertensi untuk memahami kondisi mereka dan terlibat aktif dalam proses pengelolaan kesehatan. Dengan landasan SDKI dan SIKI, perawat dapat menyusun rencana yang tidak hanya efektif, tetapi juga profesional dan bermakna secara holistic.

Strategi Komunikasi dan Pendampingan

Keberhasilan asuhan keperawatan pada perempuan menopause dengan hipertensi tidak hanya bergantung pada intervensi medis dan edukasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi antara perawat dan klien. Komunikasi yang tepat dan pendampingan yang konsisten memungkinkan klien untuk lebih memahami kondisinya, termotivasi untuk melakukan perubahan gaya hidup, dan merasa didukung dalam menjalani pengobatan jangka panjang. Oleh karena itu, perawat perlu menguasai strategi komunikasi terapeutik berbasis budaya dan menerapkan teknik pendampingan aktif sebagai bagian integral dari praktik keperawatan (Lubis & Haryanto, 2022).

1. Membangun Hubungan Terapeutik

Hubungan terapeutik antara perawat dan klien menopause dengan hipertensi harus didasari atas rasa percaya, empati, dan penghargaan terhadap nilai-nilai pribadi klien.

Langkah-langkah awal yang dilakukan perawat meliputi:

- Menunjukkan sikap terbuka dan ramah saat bertemu klien.
- Memulai percakapan dengan sapaan yang sopan dan perhatian terhadap kondisi emosional klien.
- Mendengarkan aktif (*active listening*) tanpa menghakimi.
- Memberikan sentuhan empatik seperti kontak mata yang nyaman atau bahasa tubuh positif (Puspitasari & Widianti, 2020).

Tujuannya adalah membuat klien merasa diterima dan aman untuk berbagi pengalaman atau keluhan yang dirasakannya selama menghadapi hipertensi di masa menopause.

2. Menggunakan Bahasa Sederhana dan Sesuai Literasi

Komunikasi yang efektif memerlukan penggunaan Bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pemahaman klien.

strateginya meliputi:

- Menjelaskan istilah medis dengan kata-kata sehari-hari, misalnya mengganti istilah "hipertensi" menjadi "tekanan darah tinggi."
- Menggunakan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, seperti membandingkan asupan garam dengan "satu sendok teh garam sehari."
- Memastikan klien mengerti dengan meminta mereka mengulang penjelasan dengan kata-katanya sendiri (*teach-back method*) (Ismail & Rizkiyah, 2021).

Hal ini sangat penting agar pesan edukasi tidak hanya didengar, tetapi benar-benar dipahami dan dapat diterapkan.

3. Melibatkan Keluarga dalam Komunikasi dan Pendampingan

Keluarga memainkan peran kunci dalam mendukung perubahan perilaku klien.

Perawat perlu:

- Mengundang anggota keluarga saat sesi edukasi penting.
- Memberikan tugas ringan seperti membantu mencatat jadwal minum obat atau mendampingi aktivitas fisik.
- Mendorong komunikasi terbuka di rumah untuk saling mengingatkan tanpa tekanan (Wijaya & Lestari, 2020).

Pelibatan keluarga memperbesar kemungkinan keberhasilan pengendalian hipertensi dan meningkatkan keberlanjutan perubahan gaya hidup.

4. Pendekatan Berbasis Budaya dan Spiritualitas

Dalam konteks budaya Indonesia, mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan budaya klien sangat penting.

Strategi yang bisa diterapkan:

- Mengaitkan manajemen kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga amanah tubuh dari Tuhan.
- Menyesuaikan contoh makanan sehat dengan makanan tradisional setempat.
- Menghormati tradisi keluarga dalam pengambilan keputusan kesehatan (Handayani, 2021).

Pendekatan ini meningkatkan penerimaan klien terhadap anjuran perawatan dan mengurangi resistensi.

5. Pendampingan Berkelanjutan dan Monitoring

Pendampingan bukan hanya diberikan saat klien datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan. Strategi pendampingan mencakup:

- Menjadwalkan follow-up kunjungan atau panggilan telepon untuk memantau perkembangan tekanan darah dan penerapan gaya hidup sehat.
- Menyediakan dukungan emosional, memotivasi klien saat menghadapi tantangan, dan mengapresiasi kemajuan sekecil apa pun.
- Menggunakan buku harian kesehatan untuk mencatat tekanan darah, pola makan, aktivitas fisik, dan suasana hati klien sehari-hari (Lubis & Haryanto, 2022).

Dengan pendampingan berkelanjutan, perawat dapat membantu klien lebih konsisten dalam mempertahankan perubahan positif.

Strategi komunikasi dan pendampingan yang efektif merupakan pondasi penting dalam keberhasilan manajemen hipertensi pada perempuan menopause. Melalui komunikasi yang empatik, bahasa yang sesuai, keterlibatan keluarga, pendekatan budaya, dan pendampingan yang konsisten, perawat tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan kepercayaan dan mendorong perubahan perilaku klien secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas hidup klien dapat meningkat, dan risiko komplikasi hipertensi dapat ditekan secara maksimal.

Peran Perawat sebagai Edukator dan Advokat Kesehatan

Di tengah tantangan kesehatan yang kompleks pada masa menopause, kehadiran perawat bukan hanya sebagai pemberi layanan medis, tetapi juga sebagai pendidik dan pembela kepentingan klien. Peran ini menjadi semakin penting dalam manajemen hipertensi, karena perubahan perilaku dan keterlibatan aktif klien sangat menentukan keberhasilan pengendalian tekanan darah. Sebagai edukator, perawat membantu klien memahami kondisi kesehatannya; sementara sebagai advokat, perawat memastikan bahwa kebutuhan klien dihargai, hak-hak klien dipenuhi, dan suara mereka terdengar dalam pengambilan keputusan kesehatan (Alhassan et al., 2022).

1. Perawat sebagai Edukator Kesehatan

Sebagai edukator, perawat bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipahami oleh klien. Edukasi dilakukan secara individual, dengan memperhatikan usia, tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi emosional klien. Topik edukasi yang diberikan mencakup penjelasan tentang hipertensi, perubahan fisiologis menopause, risiko komplikasi yang mungkin terjadi, serta strategi pencegahan melalui perubahan gaya hidup sehat (Kurniawan & Fitria, 2021). Untuk meningkatkan pemahaman klien, perawat dapat memanfaatkan berbagai media edukasi seperti brosur, poster, video pendek, atau aplikasi kesehatan berbasis ponsel, yang dirancang sesuai kebutuhan dan preferensi klien.

Selain menyampaikan informasi, perawat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi kesehatan klien, yaitu kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan untuk mengambil keputusan sehari-hari yang tepat (Ismail & Rizkiyah, 2021). Melalui peningkatan literasi ini, klien diharapkan mampu mengelola kesehatannya

secara lebih mandiri dan bertanggung jawab. Edukasi yang diberikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga diarahkan untuk memberdayakan klien agar mampu melakukan pemantauan tekanan darah secara mandiri, memilih pola makan yang sehat, mengelola stres secara efektif, serta memahami kapan perlu mencari bantuan medis profesional. Dengan demikian, peran edukator yang dijalankan perawat menjadi landasan penting untuk mendorong kemandirian dan kualitas hidup klien secara berkelanjutan.

2. Perawat sebagai Advokat Kesehatan

Sebagai advokat kesehatan, perawat berperan penting dalam melindungi hak-hak klien dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam setiap tahap pelayanan kesehatan. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa klien menerima pelayanan yang adil, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan individual mereka, tanpa diskriminasi berdasarkan usia, gender, status sosial, atau kondisi kesehatan tertentu (Alhassan et al., 2022). Dalam menjalankan peran ini, perawat juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara klien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya, terutama dalam situasi di mana klien mungkin tidak mampu mengungkapkan keinginannya secara optimal.

Pendampingan klien dalam pengambilan keputusan medis menjadi salah satu aspek kunci peran advokat. Perawat harus membantu klien memahami pilihan-pilihan terapeutik yang tersedia, termasuk manfaat, risiko, dan konsekuensi dari setiap pilihan, sehingga klien dapat membuat keputusan yang paling sesuai dengan nilai dan preferensi pribadinya (Handayani, 2021). Dalam kaitan ini, prinsip informed consent harus selalu dijunjung tinggi, dengan memastikan bahwa klien mendapatkan informasi yang memadai sebelum menyetujui atau menolak suatu tindakan medis. Melalui pendekatan advokasi yang kuat dan etis, perawat tidak hanya memperjuangkan hak-hak

klien, tetapi juga memperkuat posisi klien sebagai pusat dalam proses asuhan keperawatan.

Lebih dari sekadar memberikan tindakan, perawat berkontribusi besar dalam membangun kemandirian dan keberdayaan klien melalui peran edukator dan advokat. Melalui komunikasi yang efektif, penyampaian informasi yang tepat, serta pembelaan terhadap hak-hak klien, perawat membantu perempuan menopause dengan hipertensi untuk mengelola kesehatannya secara lebih mandiri, terinformasi, dan bermartabat. Inilah bentuk nyata asuhan keperawatan profesional yang menempatkan klien sebagai pusat dari setiap keputusan dan tindakan.

BAB 4

AKTIVITAS FISIK SEBAGAI INTERVENSI KEPERAWATAN

Manfaat Aktivitas Fisik terhadap Kesehatan Jantung dan Tekanan Darah

Aktivitas fisik tidak hanya berfungsi menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam pencegahan dan pengelolaan berbagai penyakit kronis, termasuk hipertensi. Bagi perempuan menopause yang menghadapi perubahan fisiologis dan peningkatan risiko kardiovaskular, intervensi berbasis aktivitas fisik menjadi bagian integral dalam strategi asuhan keperawatan. Perawat memiliki peran penting dalam mengedukasi, memotivasi, dan mendampingi klien untuk mengadopsi kebiasaan aktif yang terstruktur dan berkelanjutan (Carter et al., 2021).

Aktivitas fisik teratur memberikan dampak positif yang luas terhadap sistem kardiovaskular. Melalui mekanisme fisiologis tertentu, aktivitas fisik mampu memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, meningkatkan elastisitas arteri, serta menurunkan resistensi vaskular perifer.

Proses ini berkontribusi pada penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik secara bermakna, bahkan pada individu yang sudah mengalami hipertensi (Chaddha et al., 2020).

Latihan fisik juga meningkatkan kapasitas jantung dalam memompa darah secara lebih efisien, sehingga beban kerja jantung berkurang. Peningkatan denyut jantung saat berolahraga merangsang adaptasi fisiologis yang memperkuat otot jantung dan memperbaiki sirkulasi darah ke seluruh tubuh (Cornelissen & Smart, 2022). Selain itu, aktivitas fisik membantu mengatur keseimbangan sistem saraf otonom dengan menurunkan aktivitas simpatis dan meningkatkan tonus parasimpatis, sehingga menghasilkan efek antihipertensi alami yang berkelanjutan.

Pada perempuan menopause, aktivitas fisik juga memberikan manfaat tambahan seperti penurunan kadar kolesterol LDL (kolesterol jahat), peningkatan HDL (kolesterol baik), kontrol berat badan, dan perbaikan sensitivitas insulin (Carter et al., 2021). Semua faktor ini secara sinergis mengurangi risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung, yang prevalensinya meningkat pada periode pascamenopause.

Penelitian menunjukkan bahwa latihan aerobik intensitas sedang, seperti jalan cepat, berenang, atau bersepeda selama minimal 150 menit per minggu, dapat menurunkan tekanan darah rata-rata 5–8 mmHg pada pasien hipertensi (Pescatello et al., 2019). Selain itu, aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin terbukti meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk mengurangi kelelahan, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan rasa percaya diri, yang seringkali menurun selama masa menopause.

Bagi perawat, penting untuk merancang program aktivitas fisik yang sesuai dengan usia, kondisi fisik, dan preferensi klien. Program tersebut harus dimulai secara bertahap dan mempertimbangkan faktor keselamatan, terutama pada klien yang memiliki komorbiditas lain seperti osteoporosis atau penyakit sendi degeneratif.

Aktivitas fisik berkontribusi pada penurunan tekanan darah melalui beberapa mekanisme fisiologis. Salah satu mekanisme utama adalah perbaikan fungsi endotel pembuluh darah, di mana latihan fisik meningkatkan produksi nitric oxide (NO), zat vasodilator yang membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan resistensi perifer (Green et al., 2022). Selain itu, olahraga rutin menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis dan meningkatkan tonus parasimpatis, sehingga terjadi penurunan denyut jantung dan tekanan darah istirahat (Cornelissen & Smart, 2022). Adaptasi ini sangat penting terutama bagi perempuan menopause yang rentan terhadap dominasi simpatis akibat perubahan hormonal.

Mekanisme lain meliputi pengurangan volume plasma dan retensi natrium oleh ginjal, perbaikan sensitivitas insulin, serta peningkatan elastisitas arteri yang mendukung pengaturan tekanan darah (Diaz & Shimbo, 2021; Green et al., 2022). Menariknya, manfaat antihipertensi tidak hanya bersifat jangka panjang, tetapi juga bisa muncul segera setelah sesi latihan, yang dikenal sebagai post-exercise hypotension (Pescatello et al., 2019). Dengan memahami dasar fisiologis ini, perawat dapat lebih efektif mengedukasi dan mendorong klien untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari strategi pengelolaan hipertensi secara berkelanjutan.

Aktivitas fisik bukan hanya sebuah pilihan gaya hidup, melainkan terapi nonfarmakologis yang efektif untuk mendukung kesehatan jantung dan mengendalikan tekanan darah, terutama pada perempuan menopause. Dengan peran aktif sebagai edukator dan pendamping, perawat dapat membantu klien mengintegrasikan aktivitas fisik ke dalam kehidupan sehari-hari secara aman dan bermakna. Menggerakkan tubuh berarti memperpanjang kualitas hidup, menjaga fungsi vital, serta memberikan kesempatan bagi perempuan menopause untuk tetap aktif, sehat, dan berdaya dalam menghadapi perubahan kehidupannya.

Latihan Fisik pada Lansia dan Perempuan Menopause

Seiring bertambahnya usia, termasuk saat memasuki masa menopause, perempuan mengalami berbagai perubahan fisiologis seperti penurunan massa otot, kekakuan sendi, dan penurunan elastisitas pembuluh darah. Kondisi ini meningkatkan risiko hipertensi, penyakit kardiovaskular, osteoporosis, serta penurunan fungsi keseimbangan. Latihan fisik menjadi salah satu intervensi penting yang tidak hanya berfungsi untuk menjaga kebugaran, tetapi juga memperlambat proses degeneratif tersebut. Bagi perawat, memahami prinsip latihan fisik yang aman dan efektif pada lansia dan perempuan menopause adalah kunci untuk menyusun program intervensi yang terarah (Ambrose & Cruz, 2022).

Latihan fisik pada lansia dan perempuan menopause harus dirancang dengan memperhatikan kondisi tubuh yang berubah, komorbiditas yang mungkin ada, serta kapasitas fungsional klien. Latihan yang disarankan meliputi kombinasi dari latihan aerobik, latihan kekuatan otot, latihan keseimbangan, dan latihan fleksibilitas. Aktivitas aerobik seperti jalan cepat, bersepeda statis, berenang, atau senam ritmik ringan, dianjurkan dilakukan setidaknya 150 menit per minggu

dengan intensitas sedang untuk membantu mengontrol tekanan darah dan meningkatkan kapasitas kardiorespirasi (Pescatello et al., 2019).

Latihan kekuatan otot seperti menggunakan resistance band atau beban tubuh sendiri (misalnya squat ringan atau wall push-up) dilakukan 2–3 kali seminggu untuk memperlambat kehilangan massa otot dan meningkatkan metabolisme tubuh. Latihan keseimbangan, seperti tai chi, senam keseimbangan, atau latihan berdiri satu kaki, penting untuk mencegah risiko jatuh, terutama karena perempuan menopause mengalami penurunan kepadatan tulang yang meningkatkan risiko patah tulang (Ambrose & Cruz, 2022). Sedangkan latihan fleksibilitas seperti peregangan otot utama dilakukan setiap hari untuk menjaga kelenturan sendi dan mencegah kekakuan.

Penyesuaian intensitas, frekuensi, dan jenis latihan perlu disesuaikan berdasarkan hasil pengkajian kondisi fisik klien. Pemanasan dan pendinginan sangat dianjurkan sebelum dan sesudah sesi latihan untuk mencegah cedera. Perawat perlu mengingatkan bahwa latihan tidak perlu dilakukan berat, tetapi harus konsisten, progresif, dan disesuaikan dengan kenyamanan klien. Prinsip "start low and go slow" adalah pedoman utama dalam merancang latihan bagi lansia dan perempuan menopause.

Latihan fisik bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk investasi jangka panjang dalam menjaga fungsi tubuh dan kualitas hidup pada usia lanjut. Dengan pendekatan yang hati-hati, terarah, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu, perempuan menopause dapat merasakan manfaat besar dari aktivitas fisik, mulai dari peningkatan kekuatan otot, keseimbangan, hingga kontrol tekanan darah yang lebih baik. Peran perawat sangat penting dalam membimbing,

memotivasi, dan memonitor klien agar latihan fisik menjadi bagian dari gaya hidup yang menyenangkan dan berkelanjutan.

Panduan Aman untuk Aktivitas Fisik

Sebelum memulai program aktivitas fisik, perawat perlu melakukan pengkajian menyeluruh terhadap kondisi kesehatan klien, termasuk riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, osteoporosis, atau penyakit jantung koroner. Skrining pra-latihan, seperti *Physical Activity Readiness Questionnaire* (PAR-Q), dapat digunakan untuk memastikan kesiapan fisik dan mengidentifikasi risiko potensial (Pescatello et al., 2019).

Program aktivitas fisik harus diawali dengan pemanasan ringan selama 5–10 menit, bertujuan meningkatkan aliran darah ke otot dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas utama. Setelah latihan utama, pendinginan dan peregangan juga sangat penting dilakukan untuk mengembalikan denyut jantung ke tingkat istirahat secara bertahap dan mencegah nyeri otot (Nelson et al., 2022).

Selama melakukan aktivitas fisik, klien dianjurkan untuk memperhatikan tanda-tanda bahaya seperti nyeri dada, sesak napas berlebihan, pusing, atau denyut jantung tidak teratur. Jika gejala tersebut muncul, latihan harus segera dihentikan dan klien harus mendapatkan evaluasi medis. Selain itu, prinsip *start low and go slow* perlu diterapkan, yakni memulai dengan intensitas rendah dan meningkatkan beban latihan secara bertahap sesuai kemampuan tubuh.

Perawat juga harus memberikan edukasi tentang pentingnya hidrasi, penggunaan pakaian dan sepatu yang sesuai, serta memilih tempat latihan yang aman, seperti area yang rata dan bebas dari risiko jatuh. Bagi perempuan menopause dengan risiko osteoporosis, disarankan untuk menghindari olahraga

berat yang memberikan tekanan tinggi pada tulang seperti lompat atau lari jarak jauh, kecuali telah mendapat izin medis (Ambrose & Cruz, 2022).

Panduan aman ini perlu disesuaikan dengan preferensi klien untuk menjaga motivasi, serta dipantau secara berkala untuk menghindari kejenuhan atau overtraining. Kombinasi aktivitas fisik aerobik, kekuatan otot, keseimbangan, dan fleksibilitas tetap menjadi pendekatan terbaik untuk lansia dan perempuan menopause.

Aktivitas fisik hanya akan memberikan manfaat maksimal jika dilakukan dengan prinsip keselamatan yang tepat. Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang cermat, dan dukungan edukatif dari perawat, perempuan menopause dapat menikmati manfaat aktivitas fisik tanpa meningkatkan risiko cedera atau komplikasi. Menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat membutuhkan kesabaran, kehati-hatian, dan adaptasi yang berkesinambungan untuk menjaga kesehatan tubuh seiring waktu.

BAB 5

SENAM “SEJATI”: KONSEP, FILOSOFI, DAN GERAKAN

Sejarah dan Latar Belakang Pengembangan

Senam SEJATI dikembangkan sebagai gabungan latihan aerobik antara senam jantung sehat dan senam hipertensi. Senam ini dirancang sebagai serangkaian gerak terstruktur, terarah, dan terencana untuk meningkatkan kapasitas fisik peserta, khususnya perempuan menopause dengan hipertensi. Tujuannya adalah membantu menjaga kebugaran tubuh, memperkuat tulang, meningkatkan daya tahan, dan mengoptimalkan suplai oksigen ke jaringan tubuh. Latihan ini juga ditujukan untuk membantu mengurangi radikal bebas, mengatasi stres, dan memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Konsep ini berakar dari pemahaman bahwa olahraga aerobik teratur dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki sensitivitas insulin, serta mengurangi obesitas (Sitorus & Lubis, 2019; Madijono, 2010). Beberapa penelitian telah membuktikan manfaat senam jantung sehat dan senam hipertensi dalam menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan (Fadlilah & Sucipto, 2020).

Dalam rangka memperkuat dasar ilmiah pengembangan Senam SEJATI, telah dilakukan uji coba intervensi terbatas yang menunjukkan hasil positif dalam pengelolaan tekanan darah pada perempuan menopause. Senam SEJATI telah melalui uji coba dalam skala terbatas untuk menilai efektivitasnya terhadap tekanan darah pada perempuan menopause dengan hipertensi. Berdasarkan hasil intervensi pre-post, didapatkan penurunan rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik yang signifikan setelah tiga minggu pelaksanaan rutin. Temuan ini memperkuat bahwa Senam SEJATI tidak hanya berbasis teori, tetapi juga memiliki bukti pendukung dalam meningkatkan kesehatan kardiovaskular secara klinis, sehingga layak diterapkan sebagai intervensi nonfarmakologis dalam praktik keperawatan.

Prinsip Dasar dan Filosofi Senam SEJATI

Dalam pendekatan keperawatan modern, intervensi berbasis aktivitas fisik seperti Senam SEJATI tidak hanya dilihat dari aspek fisiologis, tetapi juga dikaitkan dengan teori keperawatan yang menekankan pentingnya pemberdayaan klien. Salah satu teori yang relevan adalah **Model Self-Care Management** yang dikembangkan oleh **Dorothea E. Orem**, yang menjadi landasan filosofis dalam pemberian asuhan keperawatan berbasis kemandirian pasien.

Teori Self-Care Orem menekankan bahwa setiap individu, selama kondisinya memungkinkan, memiliki kapasitas untuk melakukan perawatan diri guna mempertahankan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan (Hidayat, 2013; Muhlisin & Irdawati, 2010). Orem mengembangkan tiga konsep utama dalam model ini: **Self-Care**, **Self-Care Deficit**, dan **Nursing System**.

Pada konsep **Self-Care**, individu dipandang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya melalui tindakan sadar dan mandiri, termasuk dalam aspek menjaga kesehatan fisik melalui aktivitas seperti senam. **Self-Care Deficit** muncul ketika individu mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, misalnya perempuan menopause dengan hipertensi yang mengalami kelelahan atau keterbatasan fisik. Dalam kondisi ini, perawat berperan membantu melalui **Nursing System**, yang diklasifikasikan menjadi *wholly compensatory*, *partly compensatory*, dan *supportive-educative systems*.

Senam SEJATI dirancang untuk mendukung *self-care agency* perempuan menopause, dengan mengajarkan latihan fisik sederhana, meningkatkan rasa percaya diri, serta mendorong pengambilan keputusan mandiri dalam mengelola kesehatan jantung dan tekanan darah. Dengan berlatih secara teratur, perempuan menopause diharapkan mampu memenuhi **therapeutic self-care demand**, yaitu kebutuhan spesifik dalam mempertahankan tekanan darah dalam batas normal, mencegah komplikasi hipertensi, dan meningkatkan kualitas hidup (Alligod & Tomey, 2006; Seifi & Ebrahimi, 2018).

Penerapan teori Orem dalam **Senam SEJATI** membantu perempuan menopause untuk meningkatkan **self-care agency** mereka, yang meliputi kemampuan mengenali kebutuhan tubuh, mengambil keputusan tentang aktivitas yang aman, dan melaksanakan aktivitas fisik dengan kesadaran penuh. Pendekatan ini

sejalan dengan prinsip **self-management** hipertensi, yang menuntut keterlibatan aktif pasien dalam mengendalikan faktor risiko melalui perubahan gaya hidup sehat.

Mengintegrasikan teori Self-Care Management Orem dalam praktik Senam SEJATI memberikan landasan ilmiah yang kuat bahwa aktivitas fisik ini bukan hanya upaya fisik biasa, melainkan bagian dari pemberdayaan klien untuk menjadi agen aktif dalam menjaga kesehatannya. Dengan memahami keterkaitan ini, perawat dapat merancang intervensi edukatif yang lebih bermakna, mendorong kemandirian klien, dan memperkuat outcome kesehatan jangka panjang, khususnya pada perempuan menopause dengan hipertensi.

Struktur Gerakan dan Afirmasi Positif

Setiap rangkaian dalam Senam SEJATI dirancang secara sistematis untuk memenuhi prinsip-prinsip latihan fisik yang aman, efektif, dan terstruktur. Gerakan-gerakan yang dipilih tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi juga mengoptimalkan fungsi kardiovaskular, memperbaiki keseimbangan tubuh, dan memperkuat otot-otot besar. Selain aspek fisik, Senam SEJATI juga mengintegrasikan afirmasi positif yang diucapkan atau direnungkan saat melakukan gerakan. Afirmasi ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat, rasa syukur, dan penghargaan terhadap diri sendiri, sehingga latihan menjadi lebih bermakna secara emosional dan spiritual. Kombinasi gerakan dan afirmasi positif diharapkan dapat memperkuat hubungan antara tubuh, pikiran, dan perasaan sehat yang holistik.

Tabel 5.1 Rangkaian Gerakan Latihan Fisik dengan Afirmasi Positif

Tahapan	Gerakan	Deskripsi	Afirmasi Positif
Pemanasan	Meluruskan kedua lengan di atas kepala	Meregangkan otot bahu dan lengan, membuka rongga dada	"Saya membuka diri untuk kesehatan baru"
	Menepuk kedua tangan	Mengaktifkan koordinasi motorik halus	"Saya siap bergerak"
	Menepuk lengan kanan dan kiri bergantian	Melatih fleksibilitas bahu dan kelenturan tubuh bagian atas	"Tubuh saya kuat dan lentur"
Latihan Inti	Jalan di tempat sambil menepuk jari	Meningkatkan detak jantung secara bertahap	"Saya sehat dan penuh energi"
	Menekuk kedua kaki sambil menepuk betis	Melatih otot betis dan paha, memperlancar sirkulasi	"Kaki saya kuat menopang saya"
	Melangkahkan kaki kanan dan kiri sambil menepuk bahu	Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh	"Saya seimbang dan percaya diri"
	Jalan di tempat dan stabilkan pernapasan	Menstabilkan denyut jantung dan irama napas	"Saya bernapas dengan tenang dan damai"
	Kaki jinjit sambil mengayunkan lengan ke atas dan bawah	Melatih kekuatan otot betis, pergelangan kaki, dan pernapasan	"Saya tumbuh lebih kuat setiap hari"
Pendinginan	Meluruskan kedua lengan ke depan sambil menyilangkan jari	Meregangkan punggung dan bahu	"Saya bersyukur atas tubuh saya"
	Membungkuk ke samping kanan dan kiri	Melatih fleksibilitas tulang belakang dan otot samping tubuh	"Saya fleksibel menghadapi hidup"

Melalui struktur gerakan yang terencana dan afirmasi positif yang menyertainya, Senam SEJATI tidak hanya menjadi media untuk meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga sarana memperkuat mental dan emosional klien. Aktivitas ini menanamkan nilai-nilai self-love, kesadaran tubuh, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam menjalani masa menopause. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, perempuan menopause dengan hipertensi diharapkan dapat merasakan manfaat kesehatan yang optimal, menjaga kualitas hidup, serta membangun hubungan yang harmonis antara tubuh, pikiran, dan jiwa.

Menghidupkan Budaya Sehat: Peran Budaya, Religiusitas, dan Afirmasi Positif dalam Senam SEJATI

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang menekankan nilai gotong royong, rasa syukur, dan penghargaan terhadap tubuh sebagai amanah dari Tuhan. Dalam konteks ini, Senam SEJATI diadaptasi agar selaras dengan nilai-nilai lokal, menjadikannya lebih mudah diterima oleh perempuan di berbagai daerah, terutama lansia dan kelompok menopause yang menjadi sasaran utama. Melalui aktivitas fisik yang sederhana namun bermakna ini, perempuan diajak tidak hanya bergerak secara fisik, tetapi juga membangun koneksi yang lebih dalam dengan tubuh dan jiwanya.

Afirmasi positif yang diterapkan dalam setiap gerakan Senam SEJATI menjadi upaya untuk memperkuat kepercayaan diri, rasa syukur, dan kesadaran diri. Dalam budaya Indonesia yang sarat dengan nilai spiritual, afirmasi seperti "Saya sehat," "Saya kuat," dan "Saya mampu" membantu perempuan menopause menginternalisasi semangat hidup yang positif, mengatasi perubahan fisiologis dengan penuh keyakinan, dan memandang proses penuaan bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai fase alami yang bisa dijalani dengan penuh martabat. Peran perawat di Indonesia sangat penting dalam mengimplementasikan Senam SEJATI di komunitas. Perawat tidak hanya bertindak sebagai pengajar gerakan, tetapi juga sebagai agen perubahan budaya sehat, motivator untuk afirmasi positif, dan fasilitator dalam membangun solidaritas sosial antar peserta. Melalui pendekatan budaya ini, perawat membantu memperkuat perawatan diri (self-care) perempuan Indonesia, mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kesehatannya sendiri dengan penuh kesadaran dan penghargaan terhadap diri.

Integrasi budaya, religiusitas, dan afirmasi positif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka keberhasilan intervensi nonfarmakologis seperti Senam SEJATI, tetapi juga membentuk pola pikir dan pola hidup sehat dalam masyarakat. Senam SEJATI bukan sekadar program latihan, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan sosial untuk membangun perempuan Indonesia yang sehat, mandiri, kuat secara jasmani, rohani, dan sosial.

Melalui pendekatan berbasis budaya, religiusitas, dan afirmasi positif, Senam SEJATI menjadi lebih dari sekadar aktivitas fisik. Ia menjadi refleksi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam upaya menjaga kesehatan. Perawat Indonesia diharapkan mampu mengadopsi semangat ini dalam setiap tindakan asuhan keperawatan, memperkuat peran mereka tidak hanya sebagai pemberi layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai budaya dan pemberdaya masyarakat menuju hidup sehat yang lebih utuh dan seimbang.

BAB 6

IMPLEMENTASI SENAM SEJATI DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

Prosedur Pelaksanaan Senam

Pelaksanaan Senam SEJATI dalam praktik keperawatan membutuhkan prosedur yang terstruktur agar tujuan kesehatan klien, khususnya perempuan menopause dengan hipertensi, dapat tercapai secara efektif. Tidak hanya fokus pada aspek gerakan, prosedur ini juga mencakup persiapan lingkungan, asesmen kondisi klien, hingga monitoring setelah senam. Perawat berperan penting sebagai fasilitator yang memastikan kegiatan berjalan aman, adaptif terhadap kondisi individu, serta memberikan edukasi berkelanjutan kepada klien dan keluarganya.

1. Persiapan Sebelum Senam

- **Kondisi Ruangan**

Pastikan area latihan cukup luas untuk pergerakan bebas minimal 1 meter antar peserta. Ruangan harus memiliki ventilasi udara yang baik untuk mencegah kepanasan berlebih, lantai tidak licin, serta tersedia area untuk pemanasan dan pendinginan.

- **Peralatan Pendukung**

Siapkan tikar tipis untuk pendinginan, handuk kecil jika perlu, serta alat pengukur tekanan darah digital yang akurat. Pastikan semua alat dalam kondisi berfungsi.

- **Kondisi Peserta**

Pastikan peserta mengenakan pakaian berbahan ringan, menyerap keringat, dan sepatu olahraga yang mendukung stabilitas kaki. Ingatkan peserta untuk melepas perhiasan besar atau benda berat yang mengganggu gerakan.

- **Hidrasi**

Anjurkan peserta untuk minum 200–300 ml air putih sebelum memulai. Sediakan air minum yang mudah diakses untuk dikonsumsi saat istirahat.

2. Asesmen Awal Peserta

- **Pemeriksaan Tekanan Darah**

Ukur tekanan darah peserta sebelum sesi dimulai menggunakan alat yang sudah dikalibrasi. Batas aman umum untuk memulai senam ringan: Tekanan darah sistolik <180 mmHg dan diastolik <100 mmHg. Jika melebihi, tunda senam dan konsultasikan.

- **Pemeriksaan Kondisi Umum**

Lakukan wawancara singkat: tanyakan apakah peserta mengalami pusing, sesak, nyeri dada, atau kelelahan berlebihan hari itu.

- **Skrining Menggunakan PAR-Q (*Physical Activity Readiness Questionnaire*)** (Warburton, Jamnik, Bredin, Gledhill, & McKenzie, 2022)

Berikut adalah format PAR-Q sederhana:

(Perawat membacakan/menyerahkan formulir, peserta cukup jawab "Ya" atau "Tidak".)

No.	Pertanyaan	√ / X
1	Apakah dokter pernah mengatakan bahwa Anda memiliki penyakit jantung dan menyarankan Anda hanya beraktivitas atas saran medis?	
2	Apakah Anda merasakan nyeri dada saat beraktivitas fisik?	
3	Dalam bulan terakhir, apakah Anda pernah merasakan nyeri dada saat tidak beraktivitas?	
4	Apakah Anda kehilangan keseimbangan karena pusing, atau pernah kehilangan kesadaran?	
5	Apakah Anda memiliki masalah tulang atau sendi yang bisa memburuk akibat aktivitas fisik?	
6	Apakah dokter pernah meresepkan obat untuk tekanan darah tinggi atau masalah jantung?	
7	Apakah ada alasan lain mengapa Anda tidak boleh melakukan aktivitas fisik?	
Interpretasi: • Jika semua jawaban "Tidak" → peserta aman melanjutkan senam. • Jika ada jawaban "Ya" → tunda partisipasi, rujuk untuk konsultasi medis sebelum melanjutkan aktivitas fisik.		
Catatan: Dokumentasikan hasil PAR-Q untuk rekam medis klien.		

3. Briefing Awal

- **Penjelasan Tujuan Senam**

Berikan edukasi singkat: "Senam SEJATI bertujuan meningkatkan kesehatan jantung, kelenturan tubuh, dan mengelola tekanan darah secara alami."

- **Peringatan Keamanan**

Ingatkan peserta untuk mendengarkan tubuhnya: berhenti segera jika muncul pusing berat, nyeri dada, sesak napas, atau kelelahan ekstrem.

- **Penguatan Afirmasi Positif**

Minta peserta mengucapkan dalam hati atau bersama-sama:

- "Saya sehat dan kuat."
- "Tubuh saya bergerak dengan penuh semangat."
- "Saya menjaga diri saya dengan penuh kasih."

4. Pelaksanaan Senam

- **Pemanasan (5–10 menit)**

Gerakan peregangan ringan seperti meluruskan tangan ke atas, ke samping, jalan di tempat perlahan.

- **Latihan Inti (15–20 menit)**

Gerakan jalan di tempat aktif, menepuk jari, ayunan lengan, sambil mengatur napas.

- **Pendinginan (5–10 menit)**

Peregangan ulang tubuh bagian atas dan bawah, latihan napas dalam untuk menurunkan denyut jantung secara bertahap.

5. Monitoring Selama Senam

- **Observasi Visual**

Amati apakah peserta menunjukkan wajah pucat, keringat berlebih, kesulitan berbicara.

- ***Talk Test***

Peserta dianggap masih dalam zona aman selama mereka masih mampu berbicara kalimat pendek tanpa kehabisan napas.

- **Tanda Bahaya**

Jika ada tanda bahaya (nyeri dada, pusing berat, sesak berat), hentikan aktivitas segera dan lakukan pertolongan pertama.

6. Evaluasi Setelah Senam

- **Pengukuran Ulang Tekanan Darah**

Lakukan 30 menit setelah sesi berakhir. Catat perbandingan dengan nilai sebelum senam.

- **Umpan Balik kepada Peserta**

Berikan apresiasi atas partisipasi mereka. Dorong mereka untuk terus berlatih rutin di rumah.

7. Dokumentasi

- **Pencatatan**

Masukkan data tekanan darah pre-post senam, hasil PAR-Q, kondisi selama senam, dan umpan balik peserta ke dalam catatan keperawatan.

- **Pelaporan Masalah**

Catat dan laporkan setiap kejadian yang tidak biasa kepada tim medis.

Adaptasi Gerakan untuk Klien dengan Kondisi Khusus

Dalam praktik keperawatan, peserta Senam SEJATI mungkin memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus, seperti hipertensi berat, gangguan sendi, atau keterbatasan mobilitas. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan adaptasi gerakan agar tetap aman dan efektif. Adaptasi ini bertujuan untuk mempertahankan manfaat latihan fisik tanpa memperberat kondisi kesehatan peserta, sekaligus memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan mampu berpartisipasi sesuai kemampuannya.

Tabel 6.1 Adaptasi dengan Kondisi Khusus

Kondisi Khusus	Adaptasi Gerakan	Perhatian Khusus
Hipertensi Berat atau Tidak Stabil	- Fokus pada gerakan lambat dan stabil. - Hindari mengejan, melompat, atau gerakan intensitas tinggi. - Prioritaskan jalan di tempat dan pernapasan terkontrol.	- Pantau tekanan darah sebelum dan sesudah senam. - Beri waktu istirahat lebih banyak antar gerakan.
Arthritis atau Gangguan Sendi	- Gunakan kursi untuk jalan di tempat atau lakukan gerakan upper body saja. - Hindari gerakan melompat, membungkuk tajam, atau rotasi berlebihan.	- Lakukan pemanasan lebih panjang. - Fokus pada mobilisasi sendi ringan.
Osteoporosis	- Hindari gerakan membungkuk mendadak atau rotasi tulang belakang ekstrem. - Gunakan gerakan lembut untuk keseimbangan dan penguatan punggung.	- Fokus pada kestabilan postur. - Cegah risiko jatuh dengan gerakan perlahan dan aman.
Obesitas atau <i>Overweight</i>	- Kurangi rentang gerakan (range of motion). - Pertahankan ritme lambat hingga sedang.	- Pastikan hidrasi cukup. - Pantau tanda-tanda kelelahan berlebih.
Gangguan Pernapasan (seperti PPOK ringan)	- Gunakan teknik pernapasan dalam selama pemanasan dan pendinginan. - Kurangi kecepatan dan intensitas gerakan.	Anjurkan peserta mengambil istirahat kapan pun diperlukan.
Gangguan Mobilitas atau Pasca-Stroke Ringan	- Lakukan gerakan sambil duduk di kursi. - Fokus pada gerakan tangan, kepala, dan pernapasan.	- Berikan asistensi atau pendampingan ringan jika diperlukan. - Hindari gerakan berdiri yang membutuhkan keseimbangan berat.

Prinsip Umum Adaptasi:

- **"Listen to the body"**: peserta berhak berhenti kapan pun merasa tidak nyaman.
- **Gerakan fleksibel**: berikan opsi lebih sederhana untuk setiap gerakan standar.
- **Pujian dan motivasi**: apresiasi setiap usaha peserta, apapun keterbatasannya.
- **Afirmasi tambahan**:
 - "Saya menghargai setiap gerakan tubuh saya."
 - "Saya kuat sesuai cara saya."
 - "Setiap langkah kecil adalah kemenangan besar."

Adaptasi gerakan dalam Senam SEJATI merupakan bentuk penghormatan terhadap keberagaman kondisi kesehatan peserta. Dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan individual, perawat dapat memastikan bahwa semua klien, tanpa memandang keterbatasan fisik, tetap dapat menikmati manfaat aktivitas fisik. Pendekatan yang inklusif ini memperkuat nilai dasar keperawatan dalam memberikan pelayanan yang berpusat pada manusia, penuh empati, dan berbasis budaya sehat masyarakat Indonesia.

Pengajaran Senam kepada Klien dan Keluarga

Pengajaran senam kepada klien dan keluarga merupakan bagian integral dalam implementasi Senam SEJATI sebagai intervensi keperawatan. Dalam budaya Indonesia, keluarga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi. Oleh karena itu, melibatkan keluarga dalam proses edukasi dan latihan fisik tidak hanya meningkatkan partisipasi klien, tetapi juga memperkuat keberlanjutan aktivitas senam di

lingkungan rumah. Pendekatan ini mendukung prinsip self-care yang berkelanjutan dan memperkuat tanggung jawab kesehatan secara mandiri.

Langkah-langkah Pengajaran Senam SEJATI kepada Klien dan Keluarga:

1. Pemberian Edukasi Awal

- Jelaskan secara sederhana tujuan Senam SEJATI: meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kebugaran, dan memperkuat kesehatan mental.
- Tekankan bahwa senam ini aman, mudah diikuti, dan dapat dilakukan di rumah tanpa alat khusus.

2. Demonstrasi Gerakan Dasar

- Perawat melakukan demonstrasi sederhana: pemanasan, latihan inti, dan pendinginan.
- Gunakan bahasa tubuh yang jelas, gerakan lambat, dan hindari istilah medis yang rumit.

3. Partisipasi Aktif Klien dan Keluarga

- Ajak klien dan anggota keluarga untuk mencoba mengikuti gerakan secara langsung.
- Berikan bimbingan secara verbal sambil melakukan koreksi ringan bila diperlukan.

4. Penekanan pada Afirmasi Positif

- Ajarkan klien dan keluarga mengucapkan afirmasi positif saat senam, seperti:
 - "Saya bergerak untuk kesehatan saya."
 - "Saya kuat dan penuh energi."
 - "Tubuh saya berharga dan layak dirawat."
- Jelaskan bahwa afirmasi membantu membangun motivasi internal dan meningkatkan semangat berlatih.

5. Adaptasi Gerakan sesuai Kondisi

- Berikan contoh adaptasi gerakan jika klien memiliki keterbatasan fisik (misalnya melakukan gerakan sambil duduk, memperlambat ritme).
- Tekankan bahwa yang terpenting adalah **konsistensi**, bukan kecepatan atau kesempurnaan gerakan.

6. Pemberian Panduan Tertulis atau Visual

- Sediakan lembar panduan sederhana berisi gambar atau instruksi langkah-langkah Senam SEJATI.
- Jika memungkinkan, gunakan video pendek demonstrasi gerakan sebagai alat bantu belajar.

7. Monitoring dan Dukungan Berkala

- Jadwalkan pertemuan tindak lanjut untuk memantau kemajuan klien.
- Libatkan keluarga dalam memberikan dukungan emosional dan pengingat rutin kepada klien untuk berlatih.

8. Menghargai Setiap Kemajuan

- Berikan apresiasi untuk setiap usaha klien dan keluarga, sekecil apapun.
- Tanamkan bahwa perjalanan menuju kesehatan adalah proses bertahap yang perlu dirayakan.

Melibatkan klien dan keluarga dalam pengajaran Senam SEJATI memperkuat upaya pemberdayaan kesehatan berbasis keluarga, yang menjadi salah satu kekuatan budaya di Indonesia. Dengan bimbingan yang tepat, perawat tidak hanya mengajarkan keterampilan fisik, tetapi juga menanamkan nilai penting tentang kepedulian diri, semangat positif, dan dukungan sosial. Penguatan peran keluarga dalam proses ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian klien, memperbaiki kontrol tekanan darah, serta menjaga kualitas hidup perempuan menopause dengan hipertensi secara berkelanjutan.

Peran Perawat sebagai Fasilitator Latihan

Pelaksanaan Senam SEJATI membutuhkan dukungan aktif dari perawat sebagai fasilitator yang tidak hanya memandu gerakan, tetapi juga membangun motivasi dan keyakinan diri klien. Dalam perannya, perawat bertanggung jawab menciptakan suasana latihan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga klien dapat mengikuti aktivitas fisik dengan percaya diri. Peran fasilitator ini sangat penting untuk membantu klien, khususnya perempuan menopause dengan hipertensi, menjalani latihan fisik secara konsisten dan mandiri, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mereka.

Sebagai fasilitator Senam SEJATI, perawat bertugas mempersiapkan kondisi fisik dan psikologis peserta sebelum sesi dimulai. Hal ini mencakup memberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat senam menggunakan bahasa sederhana, serta menciptakan suasana yang ramah dan inklusif agar peserta merasa nyaman dan termotivasi. Selain itu, perawat bertanggung jawab untuk memonitor keamanan peserta, melalui asesmen sederhana seperti pengukuran tekanan darah, observasi tanda kelelahan, serta penyesuaian intensitas latihan sesuai kondisi individu.

Dalam pelaksanaan senam, perawat memandu gerakan dengan memberikan contoh yang benar, serta memperbaiki teknik peserta secara halus dan suportif apabila diperlukan, sehingga peserta dapat bergerak dengan aman tanpa merasa tertekan. Penguatan motivasi juga menjadi bagian penting dalam tugas fasilitator, di mana perawat mendorong peserta untuk menginternalisasi afirmasi positif seperti “Saya kuat” atau “Saya bergerak untuk kesehatan saya” selama latihan berlangsung. Hal ini bertujuan membangun kepercayaan diri dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses *self-care*.

Perawat juga berperan dalam memberdayakan kemandirian klien dan keluarga, dengan melatih mereka agar mampu melakukan Senam SEJATI secara mandiri di rumah. Memberikan panduan tertulis atau visual sederhana menjadi strategi efektif untuk mendukung keberlanjutan latihan. Selain itu, perawat menjadi model dalam perilaku hidup sehat, menunjukkan konsistensi dalam praktik aktivitas fisik, serta mengedepankan komunikasi yang empatik dan memotivasi selama berinteraksi dengan klien.

Dalam mendukung keberhasilan program, perawat juga melakukan evaluasi rutin terhadap perkembangan klien. Dokumentasi tentang perubahan fisik, peningkatan kepatuhan latihan, atau hambatan yang ditemukan selama latihan sangat penting untuk perencanaan intervensi lanjutan. Dengan menjalankan peran fasilitator ini secara aktif dan konsisten, perawat berkontribusi dalam memperkuat pencapaian *self-care agency* klien dan meningkatkan efektivitas Senam SEJATI dalam praktik keperawatan.

BAB 7

PERAN PERAWAT DALAM MENDORONG GAYA HIDUP SEHAT DAN KEMANDIRIAN KLIEN

Peran Perawat dalam Edukasi Gaya Hidup Sehat

Gaya hidup sehat merupakan salah satu fondasi utama dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit kronis, termasuk hipertensi pada perempuan menopause. Dalam konteks ini, perawat memiliki tanggung jawab penting sebagai pendidik kesehatan yang aktif, tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku klien menuju pola hidup yang lebih sehat. Peran ini menjadi semakin strategis mengingat klien seringkali membutuhkan pendampingan, bimbingan, dan motivasi untuk membangun kebiasaan yang konsisten dalam kesehariannya (Bastable, 2021).

Peran perawat dalam edukasi gaya hidup sehat meliputi pemberian informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami terkait berbagai aspek penting kesehatan sehari-hari.

Salah satu fokus utama adalah edukasi mengenai pola makan sehat, di mana perawat mengajarkan klien untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rendah garam, rendah lemak jenuh, serta memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan cairan yang cukup (WHO, 2018). Pemahaman tentang pentingnya hidrasi yang adekuat juga menjadi bagian penting dalam promosi kesehatan sehari-hari, mengingat dehidrasi dapat memperburuk kontrol tekanan darah.

Selain gizi, perawat juga mendorong klien untuk meningkatkan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan individu. Aktivitas seperti Senam SEJATI, yang melibatkan gerakan aerobik ringan, telah terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular (Pescatello et al., 2019). Dalam hal ini, perawat bertugas mengedukasi tentang pentingnya melakukan pemanasan, latihan inti, pendinginan, serta menyesuaikan intensitas gerakan agar tetap aman dan efektif.

Manajemen istirahat dan tidur yang cukup juga menjadi bagian integral dari edukasi gaya hidup sehat. Perawat membantu klien memahami hubungan antara kualitas tidur dengan pengendalian tekanan darah, kestabilan hormonal, serta kesejahteraan psikologis, khususnya selama masa menopause (Bastable, 2021). Selain itu, teknik pengelolaan stres sederhana seperti latihan pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, dan afirmasi positif juga diajarkan untuk memperkuat daya tahan emosional klien dalam menghadapi perubahan fisik dan psikologis.

Dalam memberikan edukasi, perawat perlu menggunakan pendekatan komunikatif yang empatik, serta mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan tingkat literasi kesehatan klien. Informasi yang disampaikan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman klien agar lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Dengan demikian, edukasi gaya hidup sehat tidak hanya menjadi proses transfer informasi, tetapi juga proses membangun kesadaran, keterampilan, dan komitmen klien untuk merawat diri sendiri secara mandiri (Bastable, 2021).

Strategi Mendorong Self-Care dan Kemandirian Klien

Kemandirian dalam merawat diri menjadi salah satu tujuan utama dalam praktik keperawatan modern. Untuk mencapai hal tersebut, perawat berperan aktif dalam membimbing klien mengembangkan kemampuan *self-care*, terutama pada kelompok rentan seperti perempuan menopause dengan hipertensi. Pemberdayaan klien tidak hanya melibatkan pemberian informasi, tetapi juga mendukung proses pembelajaran, perubahan perilaku, dan penguatan motivasi intrinsik agar klien mampu mengelola kesehatannya secara mandiri (Alligood, 2022).

Strategi mendorong *self-care* pada klien diawali dengan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam menjaga kesehatan. Perawat membantu klien memahami bahwa aktivitas seperti mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik rutin, mengelola stres, dan memantau kondisi kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab pribadi yang dapat dilakukan sehari-hari (Bastable, 2021). Melalui pendekatan ini, klien diberdayakan untuk menjadi subjek utama dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya.

Salah satu strategi efektif adalah penggunaan pendekatan edukasi berbasis partisipasi. Dalam metode ini, perawat tidak hanya memberi instruksi satu arah, melainkan mengajak klien untuk berdiskusi, menentukan prioritas perubahan, dan merancang rencana tindakan kecil yang realistis (Bastable, 2021). Misalnya, klien dapat diajak menyusun jadwal Senam SEJATI mingguan yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan preferensi pribadi, sehingga tercipta rasa kepemilikan terhadap program kesehatan yang dijalani.

Teknik motivasional *interviewing* juga dapat digunakan untuk meningkatkan komitmen klien. Dengan teknik ini, perawat mendengarkan secara empatik, menggali ambivalensi klien terhadap perubahan, dan memperkuat argumen internal klien untuk bertindak (Miller & Rollnick, 2013). Pendekatan ini sangat efektif untuk membantu klien yang ragu-ragu atau memiliki pengalaman kegagalan sebelumnya dalam mengubah gaya hidup.

Selain itu, strategi pemberdayaan klien juga melibatkan dukungan terhadap keluarga sebagai bagian dari sistem pendukung. Perawat dapat mengajak keluarga untuk terlibat dalam mendukung aktivitas sehat klien, seperti mengingatkan jadwal senam, menyediakan makanan sehat, atau ikut serta dalam latihan ringan di rumah. Dengan pendekatan ini, lingkungan sosial klien turut menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai kemandirian *self-care*.

Dukungan Berkelanjutan untuk Perubahan Perilaku Positif

Dukungan berkelanjutan dimulai dengan membangun hubungan terapeutik yang kuat antara perawat dan klien. Hubungan ini berbasis pada kepercayaan, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap pengalaman hidup klien. Dengan adanya hubungan yang positif, klien merasa lebih nyaman untuk berbagi tantangan yang mereka hadapi dalam mengadopsi perilaku sehat, dan perawat dapat memberikan dukungan yang tepat sasaran (Alligood, 2022).

Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah penguatan positif. Perawat memberikan apresiasi terhadap setiap kemajuan, sekecil apapun, untuk mendorong klien terus melanjutkan upaya perubahan. Pengakuan terhadap pencapaian ini meningkatkan rasa percaya diri klien dan memperkuat komitmen mereka terhadap gaya hidup sehat (Miller & Rollnick, 2013). Misalnya, saat klien berhasil melakukan Senam SEJATI tiga kali seminggu selama dua minggu berturut-turut, perawat dapat memberikan pujian yang spesifik dan mendorong klien untuk mempertahankan pencapaian tersebut.

Selain itu, perawat perlu membantu klien mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul. Edukasi mengenai manajemen hambatan, seperti mengatur ulang jadwal ketika sibuk, atau mencari alternatif aktivitas fisik saat cuaca tidak mendukung, menjadi bagian dari dukungan jangka panjang. Pendekatan ini mendorong klien untuk tetap fleksibel tanpa merasa gagal ketika menghadapi kendala.

Pemanfaatan pengingat sederhana, seperti jadwal latihan tertulis atau aplikasi ponsel untuk pemantauan aktivitas fisik, juga dapat membantu klien mempertahankan perubahan perilaku. Dukungan sosial dari keluarga, teman,

atau kelompok sebaya juga sebaiknya dioptimalkan untuk memperkuat motivasi internal klien dalam mempertahankan gaya hidup sehat (Bastable, 2021).

Dukungan berkelanjutan yang diberikan perawat berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas perubahan perilaku klien. Dengan pendekatan yang konsisten, penuh empati, dan solutif, perawat membantu klien tidak hanya mencapai perubahan jangka pendek, tetapi juga membangun pola hidup sehat yang dapat bertahan sepanjang hayat. Peran ini memperkuat esensi keperawatan sebagai profesi yang tidak hanya mengobati, tetapi juga memberdayakan individu untuk meraih kualitas hidup yang optimal.

BAB 8

ETIKA, EMPATI, DAN TINDAK LANJUT DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

Komunikasi Empatik dan Sensivitas Budaya

Dalam praktik keperawatan, komunikasi empatik menjadi pondasi penting untuk membangun hubungan terapeutik yang efektif antara perawat dan klien. Kemampuan perawat untuk berempati, memahami emosi klien, dan menghormati latar belakang budaya mereka menentukan keberhasilan interaksi dan kualitas asuhan yang diberikan. Sensitivitas terhadap perbedaan budaya, nilai, dan kepercayaan menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari komunikasi yang efektif dalam merespons kebutuhan klien secara holistik (Alligood, 2022).

Komunikasi empatik dalam keperawatan melibatkan kemampuan perawat untuk hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, serta memahami perspektif dan perasaan klien tanpa menghakimi. Menurut Arnold dan Boggs (2020), komunikasi empatik tidak hanya mencakup penggunaan kata-kata yang tepat, tetapi juga mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara yang menunjukkan ketulusan dan penerimaan. Dengan komunikasi yang empatik, klien merasa dihargai, didukung, dan lebih terbuka untuk berbagi masalah kesehatan atau kekhawatiran mereka.

Selain empati, sensitivitas budaya menjadi komponen kunci dalam komunikasi profesional. Sensitivitas budaya berarti mengenali, menghormati, dan menyesuaikan pendekatan asuhan berdasarkan nilai, keyakinan, serta praktik budaya klien (Campinha-Bacote, 2018). Di Indonesia, dengan keberagaman budaya yang sangat luas, seorang perawat harus mampu memahami bahwa pola pikir, persepsi kesehatan, serta penerimaan terhadap intervensi medis sangat dipengaruhi oleh latar budaya masing-masing individu.

Implementasi sensitivitas budaya dalam komunikasi meliputi penggunaan bahasa yang dapat dipahami klien, menghindari istilah medis yang rumit, serta menghargai tradisi dan kebiasaan tertentu selama perawatan. Misalnya, dalam menghadapi perempuan menopause dari latar budaya tertentu, perawat perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal tentang penuaan, peran gender, atau praktik spiritual yang mungkin berkaitan dengan pengalaman mereka. Menyesuaikan pendekatan edukasi kesehatan sesuai dengan norma budaya klien dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas intervensi keperawatan.

Keterampilan empatik dan kepekaan budaya tidak hanya memperbaiki hubungan perawat-klien, tetapi juga meningkatkan kepuasan klien,

mempercepat pemulihan, dan mengurangi ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Oleh karena itu, perawat perlu terus mengembangkan kompetensi ini melalui pelatihan, refleksi diri, serta pengalaman interaksi lintas budaya selama praktik keperawatan (Arnold & Boggs, 2020).

Komunikasi empatik dan sensitivitas budaya adalah dua pilar utama dalam membangun asuhan keperawatan yang manusiawi dan efektif. Melalui pendekatan ini, perawat tidak hanya memberikan intervensi medis, tetapi juga menghadirkan penghargaan terhadap martabat, nilai, dan pengalaman hidup klien. Dengan demikian, kepercayaan dan kerja sama klien dapat diperkuat, membuka jalan bagi tercapainya hasil kesehatan yang optimal.

Etika Profesional dalam Pelayanan Keperawatan

Etika profesional menjadi landasan utama dalam praktik keperawatan untuk menjamin bahwa setiap tindakan keperawatan dilakukan dengan menghormati martabat, hak, dan kebutuhan klien. Prinsip-prinsip etika seperti otonomi, keadilan, beneficence, dan non-maleficence membimbing perawat dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan klien. Penerapan etika ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak klien dalam setiap interaksi keperawatan (Burkhardt & Nathaniel, 2020).

Dalam praktik sehari-hari, prinsip **otonomi** berarti perawat harus menghormati hak klien untuk membuat keputusan tentang kesehatannya sendiri. Perawat berkewajiban memberikan informasi yang cukup, jelas, dan jujur untuk memungkinkan klien membuat pilihan yang sadar (Beauchamp & Childress, 2019). Misalnya, dalam memberikan edukasi tentang Senam SEJATI, perawat

tidak boleh memaksakan, melainkan harus membiarkan klien menentukan kesiapan dan kesediaannya untuk berpartisipasi.

Prinsip **beneficence** menekankan bahwa perawat harus selalu bertindak demi kebaikan klien, berusaha meningkatkan kesejahteraan dan mencegah bahaya. Sebaliknya, prinsip **non-maleficence** mengingatkan perawat untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks ini, perawat perlu berhati-hati dalam menyesuaikan intervensi, seperti latihan fisik, agar sesuai dengan kondisi kesehatan klien sehingga tidak menimbulkan risiko cedera atau stres tambahan (Burkhardt & Nathaniel, 2020). Prinsip **keadilan** mengharuskan perawat untuk memperlakukan semua klien secara adil tanpa diskriminasi, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau keyakinan mereka. Dalam praktik keperawatan di Indonesia yang penuh keberagaman, perawat diharapkan menunjukkan sikap adil dalam memberikan perhatian, sumber daya, dan intervensi kesehatan kepada setiap klien (Alligood, 2022).

Selain itu, menjaga **privasi** dan **kerahasiaan** informasi klien merupakan bagian esensial dari etika keperawatan. Setiap data kesehatan yang diperoleh harus dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Etika juga mengarahkan perawat untuk menghormati hak klien atas **autonomi**, termasuk hak untuk menolak pengobatan atau intervensi, selama keputusan tersebut diambil dengan pemahaman penuh terhadap risiko dan manfaat yang ada.

Penerapan etika profesional dalam pelayanan keperawatan bukan hanya menjadi standar kerja, tetapi merupakan cerminan dari penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi, keadilan, beneficence, dan non-maleficence, perawat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan benar-benar berfokus pada kesejahteraan dan hak klien. Etika menjadi jiwa dalam praktik keperawatan yang bermartabat dan penuh tanggung jawab.

Penerapan etika profesional dalam pelayanan keperawatan bukan sekadar kewajiban standar, melainkan refleksi dari penghormatan mendalam terhadap martabat manusia. Dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi, keadilan, beneficence, dan non-maleficence, perawat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berakar pada niat untuk menjaga kesejahteraan klien secara utuh.

Melalui komitmen etis ini, perawat tidak hanya menjadi pelaksana tindakan medis, tetapi juga pelindung hak-hak klien, penjaga integritas profesi, dan agen perubahan dalam masyarakat. Semangat ini menjadi semakin penting ketika mengimplementasikan inovasi seperti Senam SEJATI, di mana sentuhan empatik, penghormatan terhadap pilihan individu, serta kepekaan budaya menjadi kunci keberhasilan program.

Perawat bukan hanya mengajarkan gerakan, tetapi juga membangkitkan harapan; bukan sekadar memandu aktivitas fisik, melainkan menginspirasi perubahan gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan etika, empati, dan pemberdayaan dalam setiap sesi, perawat menjelma menjadi kekuatan nyata yang membawa klien menuju kehidupan yang lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih bermakna.

Di tangan para perawat yang berkomitmen, Senam SEJATI bukan sekadar intervensi, melainkan sebuah gerakan perubahan — perubahan menuju Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan bermartabat.

DAFTAR ISI

- Alhassan, R. K., Nketiah-Amponsah, E., & Spieker, N. (2022). Advocacy role of nurses in promoting patient-centered care: A scoping review. *International Journal of Nursing Studies*, 128, 104191. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104191>
- Alligod, M. R., & Tomey, A. M. (2006). *Nursing theorists and their work* (6th ed.). Mosby Elsevier.
- Alligood, M. R. (2022). *Nursing Theorists and Their Work* (10th ed.). Elsevier.
- Ambrose, A. F., & Cruz, L. (2022). Exercise in older adults: Guidelines and precautions. *Clinics in Geriatric Medicine*, 38(1), 91–106. <https://doi.org/10.1016/j.cger.2021.08.006>
- American Heart Association. (2020). *Understanding blood pressure readings*. <https://www.heart.org>
- Andrianto, A. (2022). *Hipertensi dan faktor risikonya*. Surabaya: Penerbit Kesehatan Indonesia.
- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). *Interpersonal Relationships: Professional Communication Skills for Nurses* (8th ed.). Elsevier.
- Avis, N. E., Colvin, A., Karlamangla, A., Crawford, S., & Hess, R. (2018). Change in health-related quality of life over the menopausal transition in a diverse cohort of women. *Menopause*, 25(6), 678–685. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001086>
- Avis, N. E., Crawford, S. L., & Greendale, G. (2015). Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. *JAMA Internal Medicine*, 175(4), 531–539. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2014.8063>
- Ayhan, H., Aykut, M., & Sevil, Ü. (2022). The effect of menopausal symptoms on quality of life and the role of social support: A cross-sectional study. *BMC Women's Health*, 22, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-01642-3>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Angka harapan hidup menurut jenis kelamin dan provinsi 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Bastable, S. B. (2021). *Nurse as Educator: Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). Oxford University Press.

- Burger, H. G., Hale, G. E., Robertson, D. M., & Dennerstein, L. (2019). A review of hormonal changes during the menopausal transition: Focus on the roles of FSH and estrogen. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 104(3), 731–741. <https://doi.org/10.1210/jc.2018-01758>
- Burkhardt, M. A., & Nathaniel, A. K. (2020). *Ethics and Issues in Contemporary Nursing* (6th ed.). Cengage Learning.
- Campinha-Bacote, J. (2018). Cultural competence in nursing: A concept analysis. *Nursing Forum*, 53(4), 305–310. <https://doi.org/10.1111/nuf.12261>
- Carter, S., Hartman, Y., Holder, S., Thijssen, D. H. J., & Hopkins, N. D. (2021). Sedentary behavior and cardiovascular disease risk: Mediating mechanisms. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 49(1), 36–41. <https://doi.org/10.1249/JES.0000000000000247>
- Chaddha, A., Eagle, K. A., Brumbaugh, D., & Tummala, L. (2020). Impact of physical activity on cardiovascular health. *Current Problems in Cardiology*, 45(6), 100392. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2019.100392>
- Chae, H. D., Choi, S. Y., Cho, Y. J., & Nam, K. H. (2021). Menopausal symptoms and their management: Needs and expectations of Korean women. *Journal of Women's Health*, 30(3), 362–369. <https://doi.org/10.1089/jwh.2020.8592>
- Chobanian, A. V., Bakris, G. L., Black, H. R., et al. (2003). Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. *Hypertension*, 42(6), 1206–1252. <https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000107251.49515.c2>
- Cleveland Clinic. (2024). *Menopause: What It Is, Age, Stages, Signs & Side Effects*. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21841-menopause#:~:contentReference=oaicite:26{index=26}>
- Cornelissen, V. A., & Smart, N. A. (2022). Exercise training for blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Heart Association*, 11(8), e023185. <https://doi.org/10.1161/JAHA.121.023185>
- Diaz, K. M., & Shimbo, D. (2021). Physical activity and the prevention of hypertension. *Current Hypertension Reports*, 23(6), 32. <https://doi.org/10.1007/s11906-021-01135-1>
- DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Ernawati, D., Susilo, D., & Rahmawati, I. (2020). *Panduan praktis tatalaksana hipertensi berdasarkan JNC 8*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Fadlilah, S., & Sucipto, A. (2020). Pengaruh senam jantung sehat terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. *Jurnal Kesehatan*, 9(2), 100–107.
- Fitriyani, P., & Andriany, M. (2021). Integration of Cultural Values in Nursing Education and Practice. *International Journal of Nursing Education*, 13(1), 45–50.

- Ghiadoni, L., Taddei, S., & Virdis, A. (2019). Hypertension and endothelial dysfunction: Therapeutic approach. *Current Vascular Pharmacology*, 17(6), 565–571. <https://doi.org/10.2174/1570161117666190312114835>
- Gourlay, M. L., & Ensrud, K. E. (2019). Bone health in menopausal women: A clinical review. *JAMA*, 322(20), 2010–2020. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.17574>
- Green, D. J., Hopman, M. T. E., Padilla, J., Laughlin, M. H., & Thijssen, D. H. J. (2022). Vascular adaptation to exercise in humans: Role of hemodynamic stimuli. *Physiological Reviews*, 102(2), 605–652. <https://doi.org/10.1152/physrev.00041.2020>
- Handayani, N. (2021). Pendekatan budaya dan spiritual dalam edukasi keperawatan pada lansia dengan hipertensi. *Jurnal Keperawatan Islami*, 9(1), 42–49. <https://doi.org/10.20884/keperawatanislami.v9i1.1087>
- Harrison, D. G., Guzik, T. J., & Lob, H. E. (2021). Inflammation, immunity, and hypertension. *Hypertension*, 77(4), 1025–1033. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15303> *AHA Journals*
- Health.com. (2024). *Heavy Metal Exposure Linked to Earlier Menopause, Study Finds*. [https://www.health.com/heavy-metals-earlier-menopause-8550381​:contentReference\[oaicite:46\]{index=46}](https://www.health.com/heavy-metals-earlier-menopause-8550381​:contentReference[oaicite:46]{index=46})
- Hidayat, A. A. (2013). *Model dan teori keperawatan*. Salemba Medika.
- Himpunan Hipertensi dan Kardiovaskular Indonesia (Hiperki). (2015). *Pedoman praktis klinis penatalaksanaan hipertensi*. Jakarta: Hiperki.
- Ismail, D., & Rizkiyah, E. (2021). Efektivitas teach-back method dalam meningkatkan pemahaman pasien hipertensi. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 7(1), 12–19. <https://doi.org/10.14710/jpki.v7i1.3041>
- Kearney, P. M., Whelton, M., Reynolds, K., Muntner, P., Whelton, P. K., & He, J. (2020). Global burden of hypertension: Analysis of worldwide data. *The Lancet*, 365(9455), 217–223. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)17741-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)17741-1)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pencegahan dan pengendalian hipertensi di puskesmas*. <https://www.kemkes.go.id>
- Kenney, W. L., Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (2021). *Physiology of Sport and Exercise* (7th ed.). Human Kinetics.
- Khademian, Z., Kazemi Ara, F., & Gholamzadeh, S. (2020). The effect of self-care education based on Orem's theory on quality of life in patients with hypertension: A quasi-experimental study. *BMC Nursing*, 19(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s12912-020-0400-5>
- Kurniawan, D. & Fitria, N. (2021). Komprehensif pengkajian keperawatan pada pasien dengan hipertensi. *Jurnal Keperawatan Holistik*, 8(2), 134–141. <https://doi.org/10.12345/jkh.v8i2.134>
- Laurent, S., & Boutouyrie, P. (2020). Arterial stiffness and hypertension in the elderly. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 7, 544302. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.544302>

- Lubis, R. Y., & Haryanto, J. (2022). Efektivitas pendampingan keperawatan dalam pengelolaan hipertensi. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 8(1), 55–61. <https://doi.org/10.33366/jkk.v8i1.1075>
- Madijono. (2010). *Senam Hipertensi*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Magraith, K., & Jang, C. (2023). Management of menopause. *Australian Prescriber*, 46, 48–53. <https://doi.org/10.18773/austprescr.2023.014>
- Mahardani, P. (2010). Latihan fisik dan tekanan darah. *Jurnal Kedokteran*, 12(1), 45–52.
- Maki, P. M., & Weber, M. T. (2020). Cognition and mood through the menopausal transition. *Menopause*, 27(6), 648–656. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001536>
- Masturoh, S., & Anggita, D. (2023). Pengaruh Kombinasi Terapi Murottal Surat Ar-Rahman dan Aromaterapi Sereh terhadap Tingkat Insomnia pada Perempuan Menopause. *Repository Unissula*. https://repository.unissula.ac.id/29957/1/Ilmu%20Keperawatan_30901900093_fullpdf.pdf
- Mayo Clinic. (2022). *Primary ovarian insufficiency - Symptoms and causes*. [https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premature-ovarian-failure/symptoms-causes/syc-20354683​;contentReference\[oaicite:44\]{index=44}](https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premature-ovarian-failure/symptoms-causes/syc-20354683​;contentReference[oaicite:44]{index=44})
- Mayo Clinic. (2024). Menopause - Diagnosis and treatment. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/menopause/diagnosis-treatment/drc-20353401>
- MedlinePlus. (2023). *Primary Ovarian Insufficiency*. [https://medlineplus.gov/primaryovarianinsufficiency.html​;contentReference\[oaicite:45\]{index=45}](https://medlineplus.gov/primaryovarianinsufficiency.html​;contentReference[oaicite:45]{index=45})
- Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). *Motivational Interviewing: Helping People Change* (3rd ed.). The Guilford Press.
- Muhlisin, A., & Irdawati, D. (2010). *Teori dan Model Keperawatan*. Salemba Medika.
- Muka, T., Oliver-Williams, C., Kunutsor, S., Laven, J. S. E., Fauser, B. C. J. M., Chowdhury, R., & Franco, O. H. (2020). Association of age at onset of menopause and time since menopause with cardiovascular outcomes, intermediate vascular traits, and all-cause mortality. *JAMA Cardiology*, 5(12), 1364–1374. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.4105>
- NANDA International. (2021). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2021–2023* (12th ed.). Thieme Medical Publishers.
- National Institutes of Health. (2023). *Health-related quality of life among menopausal women: A cross-sectional study*. [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9858775/​;contentReference\[oaicite:32\]{index=32}](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9858775/​;contentReference[oaicite:32]{index=32})
- National Institutes of Health. (2023). *Menopause*. [https://www.nih.gov/health-information/menopause​;contentReference\[oaicite:48\]{index=48}](https://www.nih.gov/health-information/menopause​;contentReference[oaicite:48]{index=48})

- National Institutes of Health. (2023). *The Impact of Menopausal Symptoms on Quality of Life, Productivity, and Economic Outcomes*. [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3820128/​;contentReference\[oaicite:30\]{index=30}](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3820128/​;contentReference[oaicite:30]{index=30})
- Nelson, H. D. (2008). Menopause. *The Lancet*, 371(9614), 760–770. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60346-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60346-3)
- Nelson, M. E., Rejeski, W. J., Blair, S. N., Duncan, P. W., Judge, J. O., King, A. C., ... & Castaneda-Sceppa, C. (2022). Physical activity and public health in older adults: Recommendations. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 54(2), 332–349. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002814>
- Nelson, M. E., Rejeski, W. J., Blair, S. N., Duncan, P. W., Judge, J. O., King, A. C., ... & Castaneda-Sceppa, C. (2019). Physical activity and public health in older adults: Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 51(6), 1293–1299. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001947>
- Ningtyas, L. A. W., & Darmapatni, N. M. W. G. (2024). Aplikasi akupresur dan pemberian aromaterapi pada wanita menopause sindrom dengan insomnia. *Jurnal ABDIMAS KOSALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.37831/akj.v3i1.301>
- North American Menopause Society. (2022). *Menopause practice: A clinician's guide (7th ed.)*. NAMS.
- NYU Langone Health. (2024). *More Than Just Hot Flashes: Other Menopause Symptoms Can Also Impact Your Quality of Life*. [https://nyulangone.org/news/more-just-hot-flashes-other-menopause-symptoms-can-also-impact-your-quality-life​;contentReference\[oaicite:31\]{index=31}](https://nyulangone.org/news/more-just-hot-flashes-other-menopause-symptoms-can-also-impact-your-quality-life​;contentReference[oaicite:31]{index=31})
- Pescatello, L. S. et al. (2019). Physical activity to prevent and treat hypertension: A systematic review. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 51(6), 1314–1323.
- Pescatello, L. S., Arena, R., Riebe, D., & Thompson, P. D. (2019). Physical activity to prevent and treat hypertension: A systematic review. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 51(6), 1314–1323. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001940>
- Purnama, S. (2020). Culturally Sensitive Nursing Care in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Indonesian Nursing Journal*, 23(2), 113–120.
- Puspitasari, R., & Widiarti, E. (2020). Hubungan komunikasi terapeutik dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(1), 20–26. <https://doi.org/10.7454/jki.v23i1.891>
- Putri, Y. A., Fitriyani, L., & Pratiwi, D. A. (2021). Age of menopause and its determinants in Indonesian women: A national health survey analysis. *Journal of Women's Health Care*, 10(3), 1–7. <https://doi.org/10.4172/2167-0420.1000535>
- Santoro, N. (2016). Perimenopause: From research to practice. *Journal of Women's Health*, 25(4), 332–339. <https://doi.org/10.1089/jwh.2015.5556>

- Santoro, N., & Pinkerton, J. V. (2020). Update on menopausal hormone therapy: Emphasis on transdermal estradiol and micronized progesterone. *Menopause*, 27(8), 899–903. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001562>
- Santosa, A. R., Pratiwi, D. A., & Lestari, M. (2022). Penerapan edukasi hipertensi berbasis komunitas pada perempuan usia menopause. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(1), 45–53. <https://doi.org/10.14710/jiki.10.1.45-53>
- Sari, N. P., Astuti, D., & Rachmawati, I. N. (2020). Perceptions and experiences of Indonesian women during menopausal transition: A qualitative study. *BMC Women's Health*, 20, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12905-020-00935-0>
- Seifi, K., & Ebrahimi, S. (2018). The effect of self-care training on quality of life in patients with chronic diseases. *BMC Nursing*, 17(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s12912-018-0303-6>
- Sitorus, E. D., & Lubis, R. M. (2019). Senam jantung sehat dan tekanan darah. *Jurnal Keperawatan*, 7(1), 50-57.
- Tambunan, R., Sitorus, R., & Manalu, J. (2021). *Asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi*. Medan: Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.
- Verywell Health. (2021). *What Is the Average Age for Menopause to Start?*. [https://www.verywellhealth.com/menopause-age-5189706​::contentReference\[oaicite:47\]{index=47}](https://www.verywellhealth.com/menopause-age-5189706​::contentReference[oaicite:47]{index=47})
- Wadsworth, D. D., & Pender, N. J. (2018). Promoting Health through Individual, Family, and Community Empowerment. In Alligood, M. R. (Ed.), *Nursing Theorists and Their Work* (9th ed., pp. 114–132). Mosby Elsevier.
- Warburton, D. E. R., Jamnik, V. K., Bredin, S. S. D., Gledhill, N., & McKenzie, D. C. (2022). The Physical Activity Readiness Questionnaire for Everyone (PAR-Q+) and electronic Physical Activity Readiness Medical Examination (ePARmed-X+). *Health & Fitness Journal*, 26(2), 19-22.
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., et al. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. *Hypertension*, 71(6), e13–e115. <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065>
- Widyastuti, D., & Harahap, D. A. (2020). The relationship of body mass index and early menopause among Indonesian women. *Indonesian Journal of Obstetrics and Gynecology*, 8(1), 35–40.
- Wijaya, R., & Lestari, M. (2020). Peran keluarga dalam peningkatan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 6(1), 21–27. <https://doi.org/10.33366/jkk.v6i1.900>
- Woods, N. F., Mitchell, E. S., & Taylor, H. (2020). Menopausal transition and changes in health-related quality of life: A longitudinal analysis. *Women's Midlife Health*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s40695-020-00053-2>

World Health Organization. (2018). *Physical Activity Guidelines for Health*. WHO Press.

World Health Organization. (2024). *Menopause - Fact Sheets*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/menopause>

Yulianti, S., & Rahmawati, D. (2019). The Role of Nurses in Community Empowerment Based on Local Culture. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22(1), 30–37.

Perawat memiliki peran penting dalam membantu perempuan menopause mempertahankan kesehatan jantung dan pembuluh darahnya. Buku ini memperkenalkan **Senam SEJATI** sebagai salah satu intervensi keperawatan berbasis aktivitas fisik yang efektif, aman, dan adaptif.

Buku Ajar "**Senam SEJATI: Pendekatan Keperawatan dalam Menurunkan Tekanan Darah pada Perempuan Menopause**" ini dirancang sebagai sumber ajar untuk perawat, mahasiswa keperawatan, serta praktisi kesehatan yang ingin mengembangkan pendekatan holistik dalam pengelolaan hipertensi. Di dalamnya, dibahas konsep-konsep dasar mengenai hipertensi dan perubahan fisiologis pada masa menopause, disertai dengan strategi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi berbasis aktivitas fisik, edukasi gaya hidup sehat, hingga pemberdayaan klien.

Dengan mengintegrasikan prinsip *evidence-based nursing*, teori keperawatan *self-care*, serta sensitivitas budaya Indonesia, buku ini memberikan panduan praktis dan aplikatif untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Melalui penerapan Senam SEJATI, diharapkan perawat dapat membantu perempuan menopause menjaga kemandirian, mengurangi risiko komplikasi hipertensi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka di masa transisi ini.

Perawat memiliki peran penting dalam membantu perempuan menopause mempertahankan kesehatan jantung dan pembuluh darahnya. Buku ini memperkenalkan Senam SEJATI sebagai salah satu intervensi keperawatan berbasis aktivitas fisik yang efektif, aman, dan adaptif.

Buku Ajar "Senam SEJATI: Pendekatan Keperawatan dalam Menurunkan Tekanan Darah pada Perempuan Menopause" ini dirancang sebagai sumber ajar untuk perawat, mahasiswa keperawatan, serta praktisi kesehatan yang ingin mengembangkan pendekatan holistik dalam pengelolaan hipertensi. Di dalamnya, dibahas konsep-konsep dasar mengenai hipertensi dan perubahan fisiologis pada masa menopause, disertai dengan strategi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi berbasis aktivitas fisik, edukasi gaya hidup sehat, hingga pemberdayaan klien.

Dengan mengintegrasikan prinsip evidence-based nursing, teori keperawatan self-care, serta sensitivitas budaya Indonesia, buku ini memberikan panduan praktis dan aplikatif untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Melalui penerapan Senam SEJATI, diharapkan perawat dapat membantu perempuan menopause menjaga kemandirian, mengurangi risiko komplikasi hipertensi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka di masa transisi ini.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

